

TEMA 45



LAS PERSONAS MAYORES: LEGISLACIÓN Y MARCO INSTITUCIONAL.

COMPETENCIAS DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID.

ASPECTOS FÍSICOS, PSICOLÓGICOS Y SOCIALES DEL ENVEJECIMIENTO.

NUEVOS ROLES DE LA PERSONA MAYOR EN NUESTRA SOCIEDAD.

POLÍTICAS DE ENVEJECIMIENTO ACTIVO Y SOLEDAD NO DESEADA.

ÍNDICE

0.- Introducción.	
1.- Las personas mayores: legislación y marco institucional.	
1.1.- Legislación. 1.2.- Marco institucional.	
2.- Competencias del Ayuntamiento de Madrid.	
3.- Aspectos físicos, psicológicos y sociales del envejecimiento.	
3.1.- Aspectos físicos del envejecimiento. 3.2.- Aspectos psicológicos del envejecimiento. 3.3.- Aspectos sociales del envejecimiento.	
4.- Nuevos roles de la persona mayor en nuestra sociedad.	
5.- Políticas de envejecimiento activo.	
5.1.- Definición de envejecimiento activo. 5.2.- Elementos esenciales: calidad de vida y envejecimiento activo. 5.3.- Claves para el envejecimiento activo. 5.4.- La perspectiva del buen trato en el envejecimiento. 5.5.- El índice de envejecimiento de la Ciudad de Madrid.	
6.- Políticas de prevención de la soledad no deseada.	
6.1.- La soledad no deseada. 6.2.- Estrategia municipal contra la soledad emocional o relacional en las personas mayores.	

O.- INTRODUCCIÓN.

El fenómeno del envejecimiento está siendo analizado desde múltiples disciplinas que aportan nuevos enfoques y permiten, poco a poco, entender la magnitud de los cambios en nuestra sociedad a nivel local, nacional y global y adoptar las medidas más adecuadas para gestionarlos.

Ciencias como la medicina, la demografía, la psicología, la economía, la sociología, la ecología, la política, etc. se afanan en analizar "la revolución de la longevidad". A nivel internacional, la OMS ha cristalizado muchos de sus hallazgos en torno a conceptos hoy ampliamente aceptados, como el **envejecimiento activo**.

El **envejecimiento activo** es la base sobre la que este organismo internacional articuló su proyecto de **ciudades amigables con las personas mayores**, que surgió hace ya 15 años en el XVIII Congreso Mundial sobre Gerontología en Río de Janeiro (Brasil) y quedó plasmado en la *Guía* para ciudades amigables con las personas mayores en 2003. El término envejecimiento activo fue adoptado por la OMS a finales de los noventa para superar el enfoque previo, muy centrado en la salud y con un claro sesgo asistencialista, y ofrecer un marco teórico basado en el reconocimiento de que todas las personas deben gozar de igualdad de oportunidades y de trato a medida que envejecen.

La relación de Madrid con el envejecimiento activo se remonta a 2002, cuando esta ciudad acogió la **Segunda Asamblea de Naciones Unidas sobre Envejecimiento**. En el marco de este evento mundial se presentó el documento ***Envejecimiento activo. Un marco político,*** pensado para aportar información y ayudar a formular planes de acción orientados a lograr un envejecimiento activo y saludable.

Multitud de ciudades en todo el mundo han apostado por el enfoque de envejecimiento activo y, como parte de esa apuesta, se han ido sumando a la Red Mundial de Ciudades y Comunidades Amigables apoyándose en la metodología plasmada por la OMS en el protocolo de Vancouver (2007) y enriquecida por la guía de Kobe (2015) para la utilización de indicadores básicos en la evaluación.

En la actualidad han aparecido nuevos planteamientos que implican una cierta evolución a la hora de establecer políticas para afrontar el envejecimiento de la población, incluidas las relacionadas con la amigabilidad de las ciudades con las personas mayores.

En primer lugar, destaca la **Agenda 2030** aprobada por la Asamblea General de Naciones Unidas en septiembre de 2015. Esta agenda establece **17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)** que se desarrollan en 169 metas. Tal y como apunta el Programa de Desarrollo de Naciones Unidas (PNUD), prepararse para una población que envejece es fundamental para que se cumplan los objetivos de la Agenda 2030 en materia de erradicación de la pobreza, salud, igualdad de género, crecimiento económico y trabajo decente, reducción de las desigualdades y ciudades sostenibles.

La OMS ha vinculado su nueva estrategia en torno al concepto de envejecimiento saludable y se ha materializado en la **Década del Envejecimiento Saludable 2021-2030.** El **envejecimiento saludable** es el proceso de desarrollo y mantenimiento de la capacidad funcional que permite el bienestar en esta etapa de la vida. La capacidad funcional comprende las capacidades intrínsecas (físicas y mentales) de cada persona, los entornos (físicos y sociales) en los que vive y la forma en que las personas interaccionan con el entorno.

El objetivo marcado en esta Década es objetivo influir en cómo las personas abordamos la segunda mitad de nuestras vidas e identifica cuatro grandes áreas de acción para promover la salud, prevenir las enfermedades, mantener la capacidad intrínseca y favorecer la capacidad funcional:

- Cambiar cómo pensamos, sentimos y actuamos hacia la edad y el envejecimiento.
- Asegurar que las comunidades fomenten las capacidades de las personas mayores.
- Proporcionar cuidados integrados y centrados en la persona y servicios de atención primaria sensibles a las necesidades de las personas mayores.
- Proporcionar cuidados de larga duración a las personas mayores que los necesiten.

La Década establece como uno de los indicadores para medir su impacto el **desarrollo de la Red de ciudades y comunidades amigables con las personas mayores.** De esta manera confirma la vigencia de este proyecto y su capacidad para transformar el espacio urbano y adaptarlo a las necesidades de una población cada vez más longeva.

El objetivo de la amigabilidad es lograr unas condiciones ambientales capaces de ofrecer diferentes respuestas a las necesidades cambiantes de las personas a medida que envejecen, y no solo en situación de dependencia o de vulnerabilidad. Una ciudad amigable es una ciudad versátil, flexible y resiliente. La amigabilidad es un concepto transversal, que implica a prácticamente todas las áreas y niveles de gobierno; precisa de acciones que no necesariamente tienen a las personas mayores como principales o únicas destinatarias, y sus efectos benefician a toda la ciudadanía. En este sentido, es una herramienta valiosa para la política municipal, ya que contribuye a desarrollar ciudades más adaptables ante la diversidad inherente a nuestra sociedad.

1.- LAS PERSONAS MAYORES: LEGISLACIÓN Y MARCO INSTITUCIONAL.

1.1.- LEGISLACIÓN.

El marco normativo en materia de personas mayores no está claramente definido, ya que no hay ninguna ley estatal que haga referencia de manera explícita a las personas mayores. Algunas Comunidades Autónomas han aprobado en el ámbito de sus competencias leyes relativas a las personas mayores. Por tanto, hacemos referencia al marco generado por la **Constitución Española** (en adelante, CE), de 27 de diciembre de 1978, que el Ayuntamiento de Madrid, como integrante del poder público tienen la obligación de garantizar. Es de destacar el **artículo 9.2** que establece que "**Corresponde a los poderes públicos promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas; remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud y facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social**".

No hemos de olvidar el principio general de no discriminación, formulado en el **artículo 14 de la CE** que, si bien no menciona expresamente la edad, sí alude a "…cualquier otra condición o circunstancia personal o social". El artículo 14 de nuestro texto constitucional consagra la obligación que tienen las Administraciones Públicas de velar por el derecho de las personas a ser tratadas en condiciones de igualdad. Entre las circunstancias de las que habla el artículo 14, ha de entenderse incluido el derecho a no ser discriminado por razón de edad, pues así lo reconoce la jurisprudencia y otros instrumentos jurídicos de los que España es parte.

En este sentido, es habitual, en el Derecho de la Unión, encontrar referencias específicas a la discriminación por razón de edad. Así la **Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea** prohíbe toda discriminación y "en particular la ejercida por razón de edad", prohibición también recogida en la **Directiva Marco 2000/78/EC**, que ya había prohibido la discriminación por motivo de edad en el entorno laboral.

El **artículo 18.1.** de la Constitución "se garantiza el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen". Para algunos autores, este artículo de la Constitución Española legitima la responsabilidad por parte de las Administraciones de desarrollar una imagen positiva, alejada de tópicos, de las personas mayores y del envejecimiento.

De especial interés resulta el **artículo 50 de la CE**: "**Los poderes públicos garantizarán, mediante pensiones adecuadas y periódicamente actualizadas, la suficiencia económica a los ciudadanos durante la tercera edad. Asimismo, y con independencia de las obligaciones familiares, promoverán su bienestar mediante un sistema de servicios sociales que atenderán sus problemas específicos de salud, vivienda, cultura y ocio**". Es este precepto constitucional el que configura el derecho de las personas mayores a la suficiencia económica, principalmente realizado a través de un sistema de pensiones, complementado con el derecho a percibir prestaciones de servicios sociales para atender sus necesidades esenciales (vivienda, salud, etc.).

La **Ley 39/2006 de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia** y el **Decreto 54/2015**, de 21 de mayo, del Consejo de Gobierno, por el que se regula el procedimiento para reconocer la situación de dependencia y el derecho a las prestaciones del sistema para la autonomía y atención a la dependencia en la Comunidad de Madrid, también involucra de manera muy clara a las personas mayores.

Por su parte, el Ayuntamiento de Madrid tiene atribuidas importantes competencias que se encuentran recogidas, en la **Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local**. Así, en su capítulo III y los artículos 25 a 27 se establecen las competencias municipales. En el caso de este Ayuntamiento se aplica también la **Ley 22/2006, de 4 de julio, de Capitalidad y de Régimen Especial de Madrid**.

Si bien no existe un tratado específico, la ONU ha promovido la incorporación de los derechos de los mayores como un eje clave en la agenda de gobiernos y sociedades, es el caso de los **Principios de la ONU en favor de las personas de edad (Resolución 46 de 1991).** Especial interés reviste la documentación asociada a las **asambleas mundiales de envejecimiento**, sobre todo la celebrada en Madrid en 2002 donde se redactó el Plan Internacional de Madrid sobre Envejecimiento.

Por su parte, la Ley Orgánica 3/1.983, de 25 de febrero de **Estatuto de Autonomía de la Comunidad de Madrid**, establece entre sus competencias, en el artículo 26.1.23, la "**promoción y ayuda a la tercera edad**, emigrantes, minusválidos y demás grupos sociales necesitados de especial atención, incluida la creación de centros de protección, reinserción y rehabilitación".

1.2.- MARCO INSTITUCIONAL.

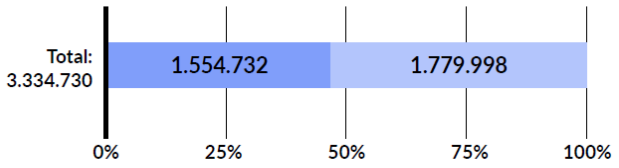
1.2.1.- PLAN DE ACCIÓN MADRID CIUDAD AMIGABLE CON LAS PERSONAS MAYORES, 2.021-2.023.

Madrid se incorporó formalmente a la Red Mundial de Ciudades y Comunidades Amigables con las Personas Mayores el 16 de mayo de **2014.**

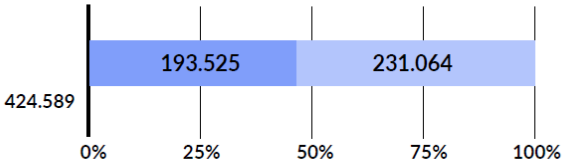
En Madrid, la población total según el Padrón Municipal de Habitantes (PMH) [1], crece de manera paulatina y asciende a 3.334.730 personas, de las que 669.043 tienen 65 años o más (20,06%). Dentro de este segmento, las personas con 80 años y más representan el 35,2% (el 7,1% en relación al conjunto de la población madrileña) y son en su mayoría mujeres, también en la franja de edad próxima a la jubilación (55-64 años).

[1] Los datos que maneja el Plan son de 1 de enero de 2.020.

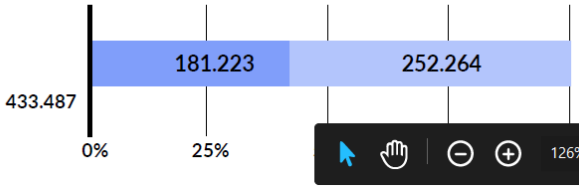
Población de la ciudad de Madrid por sexo



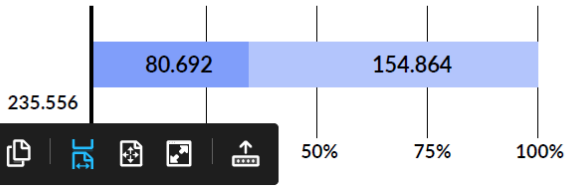
Hombres y mujeres de 55 a 64 años



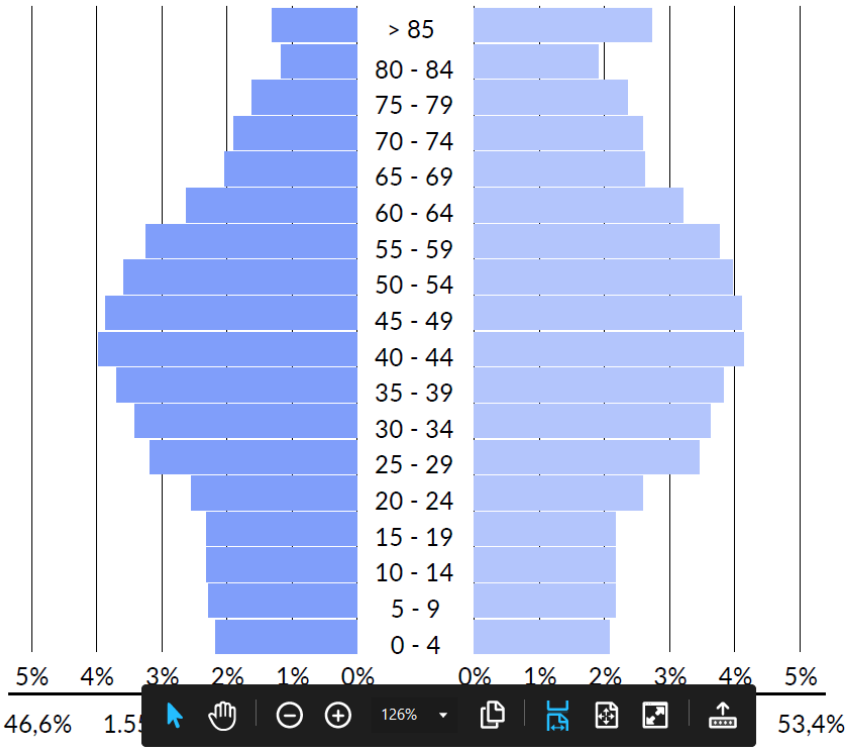
Hombres y mujeres de 65 a 79 años



Hombres y mujeres de ≥80 años



Estructura por sexo y edad de la población de Madrid



Los datos constatan la **feminización del envejecimiento.** El 53,4% de la población madrileña son mujeres y el 46,6% son hombres (115 mujeres por cada 100 hombres). A partir de los 65 años la proporción de mujeres aumenta considerablemente: 60,85% frente a 39,15% (155,4 mujeres por cada 100 hombres). El 12,2% de la población madrileña son mujeres de 65 años en adelante.

Por cada 100 habitantes de menos de 16 años, hay 143,5 con 65 años y más. Este índice se eleva por encima de la media en los distritos de **Chamberí, Moratalaz, Salamanca, Retiro y Centro**, con un índice que supera el 200%.

La **proporción de envejecimiento** (porcentaje de personas de 65 años en adelante respecto a la población total) se distribuye entre los 21 distritos de forma dispar. **Moratalaz** y **Retiro** tienen un mayor porcentaje de mayores, seguidos de **Latina** y **Chamberí.** En el otro extremo se sitúan **Villa de Vallecas** y **Vicálvaro**, donde los nuevos desarrollos han atraído a población más joven. El distrito Centro también está por debajo de la media de la ciudad.

La ***cuarta edad*, la población de 80 años o más**, representa el 7,1% de la población de Madrid y es claramente femenina: el 65,7% son mujeres. Su distribución entre los distritos es desigual. **Moratalaz, Latina, Chamberí y Salamanca** tienen un mayor porcentaje de población por encima de los 80 años, mientras que **Villa de Vallecas, Barajas y Vicálvaro** se sitúan por debajo de la media de la ciudad.

La **proporción de sobreenvejecimiento** (el porcentaje de la población de 80 años en adelante respecto al conjunto de la población de 65 años y más) en la ciudad de Madrid es del 35,2%. En los distritos de Moratalaz, Usera, San Blas y Puente de Vallecas esa cifra se eleva entre 3 y 4 puntos porcentuales, un factor a tener en cuenta en la planificación municipal.

El **nivel educativo** de las generaciones mayores es una de las variables que más va a cambiar. Actualmente, buena parte de las personas mayores de 65 años presentan un nivel educativo bajo; el 38,3% no tienen estudios o no completaron la enseñanza primaria (un 42,7% de mujeres sobre el 31,5% de hombres).

En la generación que ahora tiene entre 55 y 64 años desciende a niveles mínimos el número de personas que no saben leer ni escribir o que no tienen estudios de ningún tipo y aumenta el de quienes poseen estudios superiores. Este vuelco en el nivel educativo es aún más evidente en el caso de las mujeres.

Otro rasgo característico de nuestra sociedad es el **creciente número de hogares unipersonales**. Que una persona viva sola no significa que esté o se sienta sola, pero no es menos cierto que implica un cambio en el estilo de vida que impacta en el tejido social y debe tenerse en cuenta. En la ciudad de Madrid 164.233 personas de 65 años o más viven solas, un 24,5%. Ese porcentaje sube al 32,6% en el caso de las personas de 80 años en adelante, en su mayoría mujeres (62.797 frente a 13.988 hombres).

El **Plan Madrid Ciudad Amigable con las Personas Mayores 2.021-2.023** contempla en el diseño de sus acciones, su posterior implementación y evaluación lo dispuesto en:

- Las Directrices de Transversalidad de Género del Ayuntamiento de Madrid.
- La Estrategia Madrid 360 de sostenibilidad ambiental, cuyo objetivo es mejorar la calidad del aire.
- El Plan Sures, para reducir los desequilibrios históricos de los distritos del Sur y del Este de Madrid.
- Los Planes Integrales de Barrio.

Las acciones y actuaciones contempladas toman como punto de referencia las ocho áreas del entorno urbano y social que la OMS identifica como claves para la salud y calidad de vida de las personas y se estructuran en tres grandes ámbitos estratégicos.

OMS. **Factores del envejecimiento activo.**	**PLAN MADRID AMIGABLE, 2.021-2.023.** **Ámbitos estratégicos.**
. Respeto e inclusión social . Participación social . Comunicación e información . Participación cívica y empleo	**Ámbito estratégico 1.** Entorno cívico y social: una ciudad para todas las generaciones.
. Servicios sociales y sanitarios	**Ámbito estratégico 2.** Prevención y atención integral: una ciudad que responde a las necesidades de la población mayor.
. Espacios al aire libre y edificios . Transporte . Vivienda	**Ámbito estratégico 3.** Entorno urbano amigable: una ciudad que se adapta a todas las personas.

Estos tres ámbitos estratégicos incorporan como **enfoques transversales:**

Heterogeneidad.	La población mayor de Madrid se caracteriza por una **enorme diversidad de capacidades, necesidades, aspiraciones, inquietudes**, etc. Esta diversidad viene marcada por el amplio rango de edades que abarca la expresión "personas mayores" (que implica diferencias en cuestiones de salud, vivencias generacionales, etc.) y, sobre todo, por la riqueza de perfiles e identidades que caracterizan a las poblaciones urbanas.
Igualdad de género.	La **feminización del envejecimiento** es un hecho: la mayoría de personas de 65 años en adelante son mujeres (hay 155 por cada 100 varones), una proporción que aumenta de la tercera a la cuarta edad merced a que su esperanza de vida supera en casi 6 años a la de los hombres. Pero más allá de los datos puramente demográficos, la desigualdad estructural se traduce en una **brecha de género** evidente entre hombres y mujeres mayores, brecha con múltiples manifestaciones, como por ejemplo las diferencias en el acceso a recursos económicos, el uso del tiempo y el papel desempeñado en los cuidados, la existencia de violencia de género y una mayor prevalencia de maltrato hacia las personas mayores en las mujeres. Todo ello hace imprescindible introducir la perspectiva de género en el diseño y la ejecución de las acciones de este Plan, de forma que se tengan en cuenta las necesidades de las mujeres mayores, cuya experiencia en tanto mujeres es también distinta de la vivida por generaciones más jóvenes.
Equidad.	Para abordar las **desigualdades entre los distritos y barrios** de la ciudad, es necesario localizar y priorizar las acciones y actuaciones atendiendo a las diferentes necesidades de los territorios y sus poblaciones.

ÁMBITO ESTRATÉGICO 1. ENTORNO CÍVICO Y SOCIAL: UNA CIUDAD PARA TODAS LAS GENERACIONES.

El entorno social y cultural es determinante en la calidad de vida de las personas. El aumento espectacular de la esperanza de vida, lo que se ha dado en llamar "revolución de la longevidad", implica la construcción de un nuevo paradigma del envejecimiento que redefina el estatus de las personas mayores a nivel tanto individual como social.

La longevidad exige cambios políticos, económicos y sociales y proyectos de vida personal y comunitaria distintos que garanticen que esa vida extra que hemos conquistado se desarrolle con la mejor calidad de vida posible.

Las políticas públicas son un elemento clave para garantizar la igualdad, redefinir el estatus social de las personas mayores y el concepto mismo de la vejez, un constructo cultural que está en plena metamorfosis y que condiciona en gran medida la manera en que nos vemos y nos ven a partir de cierta edad.

Estas políticas, especialmente las municipales por ser las más cercanas a la ciudadanía, pueden ayudarnos individual y colectivamente a desarrollar un nuevo autoconcepto; llevar adelante proyectos de vida y planificar los apoyos necesarios para garantizar que esos proyectos puedan desarrollarse a lo largo de toda la vida con dignidad y autonomía.

A partir de estas premisas, las **47 acciones** y **95 actuaciones** contempladas en este ámbito fomentan el empoderamiento de las personas mayores mediante el impulso a su participación cívica y social; generan espacios de aprendizaje a lo largo de la vida, en especial -aunque no solo- para salvar la brecha digital; promueven el envejecimiento activo y saludable mediante el ejercicio físico, la actividad cultural, el asociacionismo y el voluntariado; visibilizan e intervienen ante la desigualdad de género de hombres y mujeres; desarrollan actividades intergeneracionales con sentido, etc.

Es importante señalar que las acciones propuestas tienen como escenario la ciudad de Madrid en su conjunto, no únicamente los espacios tradicionalmente asociados a las personas mayores. Si bien los Centros Municipales de Mayores siguen siendo un lugar de encuentro para muchas de ellas, la heterogeneidad de este colectivo poblacional y sus nuevas y legítimas aspiraciones implican una mirada diferente, más abierta y libre de las etiquetas que han alimentado el edadismo.

Las acciones de este ámbito estratégico tienen los siguientes **objetivos específicos:**

. Visibilizar la contribución de las personas mayores y resignificar esta etapa de la vida para cambiar la forma en que, como sociedad, concebimos, sentimos y actuamos respecto al envejecimiento.

. Mejorar la inclusión social propiciando actitudes, comportamientos y mensajes respetuosos hacia las

personas mayores.

. Combatir activamente el edadismo propiciando un nuevo relato sobre el envejecimiento que reconozca la heterogeneidad del colectivo de las personas mayores y destierre cualquier tentación de etiquetar a las personas en función de su edad.

. Desarrollar mecanismos de participación en el Gobierno municipal más ágiles y accesibles.

. Promover un nuevo modelo de Centros Municipales de Mayores más participativo.

. Visibilizar la desigualdad de género y empoderar a las mujeres mayores.

. Luchar contra la LGTBIfobia y sensibilizar sobre la situación del colectivo de personas mayores LGTBI.

. Empoderar a las personas mayores para que participen activamente en la comunidad por medio del asociacionismo y el voluntariado, con un enfoque intergeneracional, solidario y no asistencialista.

. Desarrollar actividades intergeneracionales con sentido.

. Impulsar el aprendizaje a lo largo de la vida, con especial atención a la formación en herramientas tecnológicas para salvar la brecha digital.

. Fomentar actividades culturales y de ocio diversas y de calidad.

. Informar y sensibilizar a la sociedad y a los órganos municipales sobre accesibilidad universal y su contribución a la participación social.

. Impulsar la actividad y el ejercicio físico como parte de la estrategia de envejecimiento activo y saludable.

. Promover alianzas con los mercados municipales para sensibilizar sobre el buen trato a las personas mayores.

ÁMBITO ESTRATÉGICO 2. PREVENCIÓN Y ATENCIÓN INTEGRAL: UNA CIUDAD QUE RESPONDE A LAS NECESIDADES DE LA POBLACIÓN MAYOR.

La longevidad trae consigo el regalo de una vida extra con buena calidad de vida, pero también nuevas necesidades de atención y una demanda creciente de servicios sociales y sanitarios para prevenir, retrasar y atender debidamente a las personas en situación de dependencia.

La **necesidad de articular un nuevo modelo de cuidados de larga duración** es, precisamente, uno de los ejes básicos de la Década del Envejecimiento Saludable 2021-2030 impulsada por la Organización Mundial de la Salud.

Frente a la identificación tradicional de estos cuidados con la institucionalización (residencias), este nuevo modelo de atención promueve la autonomía de las personas para que sigan viviendo en su domicilio y en su entorno recibiendo distintos apoyos, que se van adaptando e intensificando según sus necesidades para garantizar la autonomía personal.

Las acciones comprendidas en este ámbito estratégico, con un total de **38 acciones** y **101 actuaciones**, están orientadas tanto a la prevención y el mantenimiento de la capacidad funcional de las personas mayores (promoción de hábitos saludables, prevención de enfermedades y del deterioro cognitivo, formación para evitar caídas, etc.), como a la atención de aquellas que necesitan apoyo en mayor o menor grado.

Entre las medidas propuestas están los servicios de atención domiciliaria, la teleasistencia, los centros de día, etc. En todos ellos el Ayuntamiento de Madrid tiene previsto seguir avanzando en la implantación del Modelo de Atención Integral y Centrado en la Persona. Parte esencial de este modelo son también los programas y servicios dirigidos a las personas cuidadoras.

Este Plan presta especial atención al **problema de la soledad no deseada**. Este fenómeno, característico de las grandes ciudades en todo el mundo, afecta al conjunto de la población, pero tiene consecuencias especialmente perniciosas y más difícilmente reversibles en la población mayor.

La soledad no deseada es, al mismo tiempo, causa y efecto de la aparición o agravamiento de la dependencia en las personas mayores. Por ello, se incluyen en este ámbito diversas acciones encaminadas a prevenir, detectar e intervenir ante situaciones de este tipo, teniendo en cuenta factores tanto personales como sociales.

En particular, se considera el mayor riesgo de exclusión que sufren las mujeres por el hecho de que, en general, sus relaciones sociales han estado supeditadas a las de sus parejas; además, son más longevas pero viven esta etapa con peor salud y, también con carácter general, son más reacias quelos hombres a establecerse en pareja tras enviudar.

Los **objetivos específicos** de las acciones de este ámbito estratégico son:

. Desarrollar una estrategia municipal para afrontar la soledad no deseada con la participación de las personas mayores basada en la coordinación y el trabajo en red de los servicios municipales y otros agentes comunitarios, así como en la puesta en marcha de distintas estrategias para abordar el aislamiento social (app, acompañamiento telefónico, voluntariado, etc.).

. Mejorar el Servicio de Ayuda a Domicilio, avanzando en la implantación del modelo de Atención Integral Centrada en la Persona e incorporando herramientas tecnológicas para adaptar el servicio a las necesidades de las personas usuarias.

. Mejorar el Servicio de Teleasistencia para optimizar su capacidad de monitorización de los hogares y de detección de situaciones de vulnerabilidad mediante la incorporación de avances tecnológicos (teleasistencia avanzada/hogar inteligente, telemedicina, dispositivos de emergencia, etc.) y ampliar el número de personas usuarias.

. Mejorar los servicios domiciliarios de comidas, lavandería y préstamo de productos de apoyo para adaptarlos a las necesidades de las personas.

. Avanzar en la coordinación de los servicios sociales para garantizar la continuidad de la atención.

. Incrementar el número de centros de día y avanzar en la implantación del Modelo de Atención Integral Centrada en la Persona.

. Mejorar la información disponible sobre los servicios y recursos municipales dirigidos a las personas mayores y sus familias, tanto a nivel presencial como telemático.

. Impulsar la seguridad de las personas mayores en el hogar y el espacio público mediante la intervención coordinada de los distintos servicios municipales.

. Fomentar hábitos de vida saludables y prevenir y retrasar la aparición de la dependencia (envejecimiento activo y saludable), ofreciendo información y formación sobre los cambios físicos, psíquicos y sociales que implica la edad y promoviendo la resiliencia y el autocuidado de las personas mayores y las personas cuidadoras.

. Avanzar en la identificación, detección y atención frente al maltrato que sufren las personas mayores.

. Implementar medidas específicas frente a la violencia de género que sufren las mujeres mayores.

. Promover la autonomía y el bienestar de las personas mayores LGTBI.

ÁMBITO ESTRATÉGICO 3. ENTORNO URBANO AMIGABLE: UNA CIUDAD QUE SE ADAPTA A TODAS LAS PERSONAS.

Propiciar entornos libres de ruido y humos, itinerarios seguros por los que pasear y que faciliten el desarrollo de actividades significativas en el día a día es clave para el envejecimiento activo y saludable, especialmente cuando las personas tienen limitadas algunas capacidades físicas, sensoriales o cognitivas.

Este tipo de medidas son fundamentales para **transformar entornos discapacitantes en entornos amigables**, que permitan a las personas permanecer en su domicilio y su barrio con autonomía y seguridad durante toda la vida, participando activamente en la vida de su comunidad.

Las **24 acciones** y **43 actuaciones** comprendidas en este ámbito estratégico inciden en la mejora del medio físico en el que transcurre la vida en la ciudad, promoviendo avances en la accesibilidad y adaptabilidad del espacio público, los edificios, la vivienda y el transporte que contribuyan a crear un espacio público inclusivo que facilite la máxima autonomía a una población cada vez más longeva.

Mediante diversas intervenciones en las calles, aceras, plazas, jardines y parques se busca que sean lugares amables, seguros y saludables que promuevan la convivencia, la movilidad peatonal, la seguridad y la disponibilidad de zonas tanto de descanso como de ejercicio.

En cuanto a la vivienda, este plan contempla el estudio de alternativas residenciales que permitan a las personas permanecer en su casa y su entorno familiar y vecinal, en línea con el cambio de modelo en los cuidados de larga duración. Asimismo, prevé ayudas para la rehabilitación y acondicionamiento de los hogares y comunidades, así como para el acceso a viviendas gestionadas por el Ayuntamiento en régimen de alquiler y compra.

Las acciones encaminadas a mejorar la movilidad en una gran ciudad como Madrid son también fundamentales. Entre ellas destacan la promoción del transporte público, en particular del autobús, y el desarrollo de itinerarios peatonales y de carriles bici para avanzar en un nuevo modelo de movilidad más sostenible.

Estos son los **objetivos específicos** de las acciones incluidas en este ámbito estratégico:

. Avanzar en el conocimiento de alternativas residenciales para personas mayores mediante el estudio y la puesta en marcha de proyectos piloto.

. Favorecer la rehabilitación de edificios y viviendas para mejorar su accesibilidad, aislamiento térmico y acústico, adaptabilidad para incorporar productos de apoyo, etc.

. Favorecer el acceso de las personas mayores a las viviendas gestionadas por el Ayuntamiento.

. Promover la participación del movimiento vecinal en la mejora social y urbanística de los barrios (supresión de barreras arquitectónicas).

. Fomentar la participación de las personas mayores en el diagnóstico de necesidades y la planificación de acciones de mejora urbanística en los barrios.

. Mejorar el espacio público siguiendo un modelo urbanístico centrado en las personas: aumento de la superficie peatonal; renovación y construcción de nuevas aceras; mantenimiento y mejora de la accesibilidad de parques y zonas verdes; instalación de bancos; mantenimiento de áreas de mayores y circuitos deportivos elementales, etc.

. Promover la seguridad vial mediante actuaciones en el espacio público y campañas de información y sensibilización.

. Mejorar el medio ambiente urbano mediante la creación de zonas cero emisiones, la reducción del tráfico privado con la construcción de nuevos aparcamientos accesibles (tanto disuasorios como para residentes), la renaturalización de la ciudad y la mejora en la recogida de residuos urbanos (contenedores accesibles y ampliación de la red de puntos limpios de proximidad).

. Investigar la disponibilidad de suelo público en los distritos en relación con la necesidad de nuevas dotaciones para las personas mayores.

. Aumentar la seguridad de las personas mayores en el espacio público mediante intervenciones específicas de prevención y atención de los servicios de emergencias: SAMUR Social, SAMUR Protección Civil, Cuerpo de Bomberos y Policía Municipal.

. Promover el transporte público y mejorar la amigabilidad de los autobuses urbanos mediante la mejora de la flota con criterios de accesibilidad, así como la formación y la sensibilización tanto de conductoras/es como usuarias/os.

El presupuesto total del Plan de Acción Madrid Ciudad Amigable con las Personas Mayores 2.021-2.023 asciende a 906.924.380,99 euros. Las acciones de prevención y atención integral (ámbito estratégico 2), gestionadas en su mayoría por los servicios sociales municipales, concentran la mayor parte del esfuerzo presupuestario del Plan.

1.2.2.- EL APOYO A LAS PERSONAS MAYORES EN EL PLAN OPERATIVO DE GOBIERNO 2.019-2.023 [2].

El actual **Plan Operativo de Gobierno 2.019-2.023**, en su Eje Estratégico nº 2, se compromete con una **"Ciudad para todas las familias".** Uno de sus **objetivos estratégicos** es **"apoyar social y fiscalmente a las familias y sus miembros más vulnerables, como las personas mayores, las personas dependientes y la infancia".**

La **ampliación y mejora de los servicios a mayores**, asume como actuaciones:

- Desarrollo de un nuevo modelo para los centros municipales de mayores:
- Avanzar en un modelo de mayor intervención en prevención y detección de riesgos en las personas mayores usuarias.
- Impulsar la creación de más centros de mayores basado en criterios de necesidad, listas de espera y disponibilidad presupuestaria.
- Nuevo protocolo de coordinación con el Samur Social para la atención de las emergencias de las personas mayores de la Ciudad de Madrid.
- Impulso de políticas dirigidas a las personas mayores: promoción del envejecimiento activo, de la participación social y del voluntariado.
- Refuerzo de una estrategia común para potenciar el envejecimiento activo y saludable en los Centros de Mayores y en los Centros de Día Municipales.
- Creación de estructuras de valoración y seguimiento de vulnerabilidad y maltrato en el ámbito de los Servicios Sociales, tanto en los Distritos como en el Área.
- Configuración de Equipos de detección de vulnerabilidad de personas mayores en cada uno de los 21 Distritos de la ciudad.
- Ampliación de los servicios de ayuda a domicilio y de teleasistencia.
- Nueva Ordenanza del Servicio de Ayuda a Domicilio.
- Investigación y promoción de nuevas alternativas de alojamiento y vivienda compartida para los mayores.
- Desarrollo de programas intergeneracionales en los que participen personas mayores en los Centros de Día, Centros de Mayores y otros servicios de mayores.
- Plan de acceso digital para personas mayores.
- Puesta en marcha de un nuevo proyecto que integre terapia ocupacional y envejecimiento saludable.

[2] En la fecha en la que se ha elaborado este tema, a pesar de que está ya avanzado el año 2.024, no ha sido aún publicado el actual Plan Operativo de Gobierno del Ayuntamiento de Madrid.

2.- COMPETENCIAS DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID.

En el actual **Área de Gobierno de Políticas Sociales, Familia e Igualdad**, las competencias con las personas mayores son asumidas desde la **Dirección General de Mayores y Prevención de la Soledad no Deseada.**

Sus competencias específicas son las siguientes:

1. Promover cualesquiera actuaciones tendentes a favorecer un **envejecimiento generativo y el apoyo a las personas mayores y su red familiar y social**, en las diferentes facetas que comprende su atención integral.

2. Impulsar **políticas públicas de atención a las personas mayores que favorezcan la amigabilidad de la ciudad** con ellas y las sitúen en el centro de las diferentes actuaciones municipales que las incumben.

3. Favorecer la **participación de las personas mayores en la vida social de los barrios y distritos** a cuyo efecto se actualizará y potenciará, entre otras actuaciones, el papel de los actuales **centros municipales de mayores.**

4. Fomentar actuaciones tendentes a **favorecer el trato adecuado hacia las personas mayores**.

5. Impulsar políticas públicas para **prevenir la soledad no deseada en las personas mayores**.

6. Coordinar la intervención de los diferentes servicios municipales implicados con aquellas personas mayores que pudieran encontrarse en **riesgo o situación de maltrato y vulnerabilidad social**, por presentar **situaciones de soledad no deseada, aislamiento, negligencia y/o trato inadecuado**.

7. Diseñar y proponer **programas y servicios para las personas mayores**, en especial los referidos al **mantenimiento de la persona mayor en su propio hogar** todo el tiempo posible y los que tienen por objeto el **apoyo a las familias que las cuidan**.

8. Desarrollar la **política de calidad de aplicación en los servicios y prestaciones de atención a las personas mayores** de la ciudad de Madrid, implantando y evaluando periódicamente los criterios y estándares de calidad conforme a los que aquellos habrán de prestarse; auditando los distintos programas y servicios municipales para personas mayores al tiempo que realizando los correspondientes estudios de satisfacción, opinión e investigación que considere pertinentes respecto a los mismos.

9. **Planificar, dirigir y evaluar los servicios de ayuda a domicilio dispensados a las personas mayores, así como a las personas con discapacidad**.

10. Adoptar cuantas resoluciones resulten pertinentes en relación con los servicios de ayuda a domicilio, en modalidades tales como: **suministro a domicilio de alimentos preparados o servicios análogos, lavado, planchado y repaso de ropa fuera del hogar o productos de apoyo y ayudas técnicas**.

11. Planificar, dirigir y evaluar el servicio de **centros de día para personas mayores**, ya sean estos municipales o privados con plazas financiadas por el Ayuntamiento de Madrid, y centros residenciales.

12. Adoptar cuantas resoluciones resulten pertinentes en relación con los **centros de día para personas mayores, municipales o privados con plazas financiadas por el Ayuntamiento de Madrid, y centros residenciales en los términos previstos en la ordenanza** reguladora de esta materia.

13. Coordinar los servicios de **los centros municipales de mayores**, sin perjuicio de las competencias de gestión que sobre estos centros correspondan a los distritos.

14. Promocionar la **autonomía personal y la atención a las personas en situación de dependencia sobre una adecuada coordinación con la Comunidad de Madrid**, competente en la materia, y de acuerdo con la atribución competencial que corresponda al Ayuntamiento de Madrid en cada momento.

15. Diseñar y proponer programas y servicios para el desarrollo de otras **alternativas habitacionales como las viviendas colaborativas o las viviendas compartidas.**

3.- ASPECTOS FÍSICOS, PSICOLÓGICOS Y SOCIALES DEL ENVEJECIMIENTO.

3.1.- ASPECTOS FÍSICOS DEL ENVEJECIMIENTO.

3.1.1.- TEORÍAS SOBRE EL ENVEJECIMIENTO.

No existe una única teoría que explique las causas del envejecimiento. Desde una perspectiva biológica hay numerosas perspectivas que tratan de analizar porque envejecemos.

Teoría del desgaste de órganos y tejidos.

También se llama la teoría del ritmo de vida, que dice que las células del cuerpo se van estropeando conforme pasa el tiempo debido a su uso, como ocurre con los componentes de una máquina. Se conoce que las personas que han vivido forzando su cuerpo o que han tenido un estilo de vida poco saludable, han vivido menos. Los radicales libres serían las sustancias responsables del desgaste de las células relacionadas con los **estilos de vida nocivos**, sobre todo de las mitocondrias, que no tienen capacidad de reparar su ADN.

Teoría de la intoxicación por sustancias intrínsecas.

También se llama teoría de la autointoxicación. Durante la vida se acumulan **sustancias de desecho en el interior o exterior de la célula** como la lipofucsina y otros pigmentos, creatinina, colesterol en las placas de ateroma (aterosclerosis) que son productos del metabolismo celular.

Teoría autoinmune.

Está basada en dos fenómenos principalmente:

1) El sistema inmune disminuye su función tanto cualitativa como cuantitativamente, así como su dependencia del timo, convirtiendo a las personas mayores más vulnerables a las infecciones. 2) Aumento de las respuestas autoinmunes con la edad, en las que el sistema inmune no distingue entre las sustancias propias y las extrañas al organismo, por lo que aumentan las enfermedades autoinmunes. Debido a la ineficacia del sistema inmune y a la autoinmunidad se explican muchas enfermedades de los ancianos como el cáncer, la diabetes mellitus, la demencia, la artrosis, etc.

Teoría neuroendocrina.

El sistema nervioso y el sistema endocrino, al igual que el sistema inmunológico se encargan de la homeostasis del organismo para superar los cambios del medio ambiente y mantener la supervivencia. La pérdida de funciones del sistema neuroendocrino (menopausia, pérdida de neuronas, demencia), no es universal en todos los seres vivos, ni en todos los seres humanos (como por ejemplo la demencia) y posiblemente se deba a la edad y no a la inversa.

Teoría de la programación genética.

Desde que nacemos tenemos una determinada información genética, en la que está incluida la longevidad del organismo. La longevidad de una determinada especie estaría predeterminada por mecanismos genéticos y serían las circunstancias ambientales o patológicas acumuladas durante la vida de cada uno las que limitarían, en mayor o menor medida, esa programación.

Los que hablan de la mutación somática postulan que la acumulación de un nivel significativo de estas mutaciones en las células daría lugar al envejecimiento. La teoría del error genético se refiere a que estas mutaciones se derivarían en la pérdida de una secuencia de DNA.

3.1.2.- CAMBIOS FÍSICOS PRODUCIDOS EN EL ENVEJECIMIENTO.

El hecho más importante de los cambios físicos intrínsecos al envejecimiento es su **inevitabilidad**, no podemos erradicarlos ya que forman parte del proceso biológico natural.

Otro cambio importante es que, a medida que envejecemos, somos más susceptibles de padecer enfermedades, pudiéndose muchas de ellas desarrollar como **enfermedades crónicas**. Los ancianos tienen más posibilidades de experimentar enfermedades comunes y de contraer algunas enfermedades características de la vejez.

Con el paso del tiempo en los sistemas y aparatos que componen el organismo se producen una serie de modificaciones, que afectan tanto a la estructura como a la función corporal.

Se va a producir una **tendencia a la atrofia**, observable en:

- Disminución del peso y volumen en los órganos.
- Disminución del contenido hídrico.
- Reducción de la vascularización capilar.

Igualmente se produce una **disminución de la eficacia funcional**, por dos factores:

- Descenso del número de células (se considera que pueden perderse 100.000 células nerviosas al día).
- Aumento del tamaño celular, para contrarrestar la pérdida de elementos celulares. Las células hipertrofiadas presentan una distribución más irregular dentro del tejido.

A nivel **músculo-esquelético**:

- Aumenta la rigidez del colágeno de las articulaciones con la consiguiente pérdida de elasticidad y aparición de artrosis en las personas mayores de 55 años.
- Aumenta la densidad por pérdida de agua de las articulaciones vertebrales, con lo que disminuye la estatura y la flexibilidad.
- Las articulaciones del miembro inferior –al presentar mayor presión y desgaste- presentan importantes cambios: es una zona más frágil y quebradiza, lo que explica las frecuentes fracturas. La pérdida de fuerza de los músculos y ligamentos dan lugar a la aparición de callosidades y dificultades en el equilibrio corporal, la alineación y la marcha.

En relación a las funciones musculares, quedan significativamente afectadas:

- Pérdida gradual de fuerza muscular.
- Prolongación del tiempo de contracción y de relajación.
- Descenso en el desarrollo máximo de tensión.

En relación a los **cambios en el sistema cardiovascular**, se van a producir:

- Cambios anatómicos cardíacos: hipertrofia miocárdica, reducción del número de fibras miocárdicas, engrosamiento y rigidez de las válvulas cardíacas …
- Cambios anatómicos vasculares: rigidez de las paredes arteriales, disminución de la elasticidad de las fibras colágenas, engrosamiento de las membranas basales …

Los cambios funcionales a nivel cardiovascular implican una disminución del gasto cardíaco y de la frecuencia cardíaca en respuesta al estrés o al ejercicio, aumenta la presión arterial, disminuye el tono vasomotor …

Los **cambios en la sangre y en el sistema inmunitario** no van a ser demasiado significativos, ya que no disminuye el volumen sanguíneo. Es frecuente la anemia en los ancianos, pero no parece ser tanto consecuencia del envejecimiento como de la respuesta al estrés.

Los **cambios en el sistema respiratorio** vienen determinados por un conjunto de cambios morfológicos:

- Disminución de la movilidad de las costillas y contracción parcial de los músculos respiratorios.
- Reducción de la adaptabilidad de la pared torácica, el pulmón se vuelve más rígido.
- Reducción en el número de alvéolos, se produce una atrofia de las paredes alveolares.

A nivel funcional disminuye el flujo expiratorio forzado, la capacidad respiratoria máxima, disminuye la efectividad propulsiva de la tos –por la reducción de fuerza de los músculos respiratorios-, pueden darse complicaciones mecánicas e infecciosas por la retención de secreciones en tráquea y bronquios …

A nivel del **sistema gastrointestinal**, los cambios morfológicos son:

- Disminución de la producción de saliva, erosión de la dentina y el esmalte, retracción de las encías …
- Descenso del número de fibras musculares del esófago.
- Atrofia de la mucosa gástrica del estómago.
- Descenso del tamaño hepático.

Estos cambios van a producir modificaciones a nivel funcional:

- Se detectan reducciones en la amplitud de las contracciones esofágicas por debilidad en la contracción del músculo liso.
- Hay una disminución del tono muscular intestinal, con lo que se puede producir incontinencia fecal debido a la disminución del tono del esfínter y a las heces semilíquidas.
- Descenso de la secreción de ácido gástrico.
- Disminución de la eficacia en los mecanismos de estabilización y absorción del colesterol.

Se van a producir **cambios en la función renal** que van a implicar la disminución moderada de la capacidad de concentración de la orina.

A nivel del **sistema nervioso** el encéfalo se mantiene estable hasta los 50 años, para ir disminuyendo un 2% cada década. Se pierde antes la materia gris que la materia blanca.

- Se va a producir una reducción del flujo sanguíneo cerebral.
- Adelgazamiento de las circunvoluciones cerebrales, tendencia a la atrofia cortical y a la dilatación ventricular.
- Se producen diversas lesiones anatómicas relacionadas con la demencia senil. Las más comunes son las placas seniles y los cúmulos neurofibrilares.

Los cambios en los **órganos de los sentidos** son numerosos.

- En el ojo se produce una pérdida de la elasticidad del músculo orbital con la consiguiente disminución de la movilidad ocular, hay una pérdida de la grasa orbital –produciendo un hundimiento de los ojos de la órbita-, disminuye la agudeza visual, desciende la capacidad de acomodación …
- Más de la tercera parte de los mayores de 75 años experimentan pérdida auditiva. Aumenta el umbral medio para todos los tonos y para todas las frecuencias en ambos sexos.
- Hay una disminución en el número de papilas gustativas, se pierde la capacidad de detección de sabores salados.
- Hay una reducción de la capacidad de identificación olfatoria.
- Se reduce la agudeza en el sentido del tacto.

En relación al **aparato reproductor**, diferenciamos entre los cambios que se producen en el hombre y en la mujer.

- En el hombre la pérdida de testosterona supone la disminución del tamaño y firmeza de los testículos, la degeneración de los túmulos seminíferos, la disminución del volumen y viscosidad del líquido seminal, la hipertrofia prostática –las contracciones son más débiles-.
- En la mujer la disminución de los estrógenos va acompañada de la atrofia del útero y de la vagina, la regresión en los caracteres sexuales secundarios …

En el **sistema tegumentario**, los cambios se producen en piel, pelo y uñas.

- En la piel adelgazan las capas celulares de la epidermis, las células se vuelven grandes e irregulares, desciende la función fotoprotectora, disminuye la inmunidad celular cutánea, hay un aumento de la fragilidad vascular –con lo que se reduce el número de capilares dando lugar a palidez cutánea y dificultando los procesos de cicatrización-, el colágeno se hace más rígido –dando lugar a arrugas y a flojedad en la piel-, disminuyen las glándulas sudoríparas –produciéndose sequedad en la piel- …
- Disminuye el diámetro del tallo del pelo –parte que emerge de la piel-, disminuye la velocidad de crecimiento …
- La velocidad de crecimiento de las uñas es menor y se reduce el aporte vascular, dando lugar a uñas mates, quebradizas, duras y gruesas.

Estos cambios y deterioros van a dar lugar a la **aparición de enfermedades crónicas:** se trata de enfermedades prolongadas, progresivas y –habitualmente- incurables. La mayor parte de las enfermedades crónicas que afectan a los ancianos no tienen una causa externa identificable. No es posible plantearlas desde intervenciones que produzcan curaciones a corto plazo, sino desde la prevención y el tratamiento a largo plazo. Los procesos crónicos más frecuentes están relacionados con procesos cardíacos, hipertensión, artritis, diabetes, etc.

Las enfermedades crónicas influyen en los ancianos de muy diversas maneras, y su presencia se asocia a pérdida intelectual, disminución del deseo y de la actividad sexual, depresión y otros problemas emocionales.

Aunque están íntimamente relacionadas no son lo mismo una enfermedad crónica que la incapacidad. La incapacidad constituye el parámetro conductual de estas enfermedades, y se determina mediante el nivel de **deterioro funcional.** Se han desarrollado numerosas escalas para valorarlo, midiendo tanto las capacidades del anciano en el ámbito físico como en el ámbito psicosocial.

Estas escalas no miden un elemento que es fundamental: el **entorno**, ya que éste puede incrementar las posibilidades físicas del individuo o exagerar sus incapacidades, provocando un deterioro desproporcionado. Se producen en estos casos las llamadas **incapacidades excesivas**, debidas a que la situación vital del individuo actúa como un obstáculo de su funcionamiento independiente. También el exceso de atenciones puede producir este tipo de incapacidad, ya que la inactividad de los ancianos debilita y acelera su declive fisiológico.

3.2.- ASPECTOS PSICOLÓGICOS DEL ENVEJECIMIENTO.

Los cambios psíquicos atribuibles a la edad hay que considerarlos como la correlación entre diversos factores:

- Las modificaciones anatómicas y funcionales en las estructuras cerebrales.
- Las modificaciones en las funciones cognitivas: inteligencia, memoria, resolución de problemas, creatividad.
- Las modificaciones en la efectividad: vivencia de las pérdidas, motivación, personalidad.

3.2.1.- MODIFICACIONES DE LAS FUNCIONES COGNITIVAS.

La disminución de las funciones cognitivas durante el envejecimiento suele vivirse como una gran amenaza para el bienestar e incluso para la integridad personal. Resulta difícil generalizar el alcance de estas pérdidas, ya que la persona anciana se va adaptando poco a poco a estas pérdidas, ensayando y poniendo en práctica estrategias sustitutorias para los déficits que se van produciendo.

Los componentes de la inteligencia humana (percepción, razonamiento, abstracción, formación de conceptos y resolución de problemas) están influenciados por múltiples aspectos personales, educaciones, culturales y del propio entorno.

La inteligencia.

La edad, por sí sola, no parece ser un factor que modifique de forma apreciable la utilización de las facultades mentales, aunque los mayores suelen utilizar los conocimientos adquiridos a lo largo de toda su vida para compensar la lentitud de respuesta a distintos estímulos. Este hecho nos permite identificar la estabilidad como una de las principales características de la **inteligencia en los mayores**.

El **enlentecimiento de las capacidades intelectuales** es el factor clave que hay que tener presente en los cambios psíquicos, y su traducción en el comportamiento individual se caracteriza por:

- Fatiga intelectual.
- Pérdida de interés.
- Pérdida de atención y/o dificultad en la concentración.

Con frecuencia este cambio de ritmo es un reflejo del enlentecimiento general del organismo, ya que el anciano precisa invertir más cantidad de energía para adaptarse a las diferentes situaciones que le plantea su proceso de envejecer.

La inteligencia denominada fluida guarda relación con el aprendizaje. En ella se sitúa la creatividad, el comportamiento innovador y permite al individuo la resolución de nuevos problemas. La inteligencia cristalizada la relacionamos con la experiencia y la reflexión. Está vinculada a aspectos culturales, educacionales y de experimentación. Permite al individuo la respuesta a los problemas utilizando estrategias aplicadas en la resolución de situaciones ya vividas. La **inteligencia fluida**, que depende de la rapidez para adaptarse eficazmente a situaciones nuevas, estará disminuida.

El **razonamiento verbal** no parece sufrir cambios, aunque sí se aprecia una ligera pérdida en la capacidad para la conceptualización y en la flexibilidad mental. Se observa también un declive en la **agilidad mental** precisa para la coordinación de movimientos, especialmente relacionada con el funcionamiento de la vista y el oído.

La memoria.

La **pérdida de memoria reciente** parece ser el signo general característico de los cambios psíquicos, durante el envejecimiento. A la persona le resulta difícil evocar sucesos recientes y sufre con frecuencia pequeños olvidos. En este fenómeno interrelacionan numerosos factores: los cambios neurológicos y circulatorios que afectan a la función cerebral, la oxigenación y nutrición celular, la motivación, la pérdida de interés por el entorno, los sentimientos de impotencia, los estados depresivos, la vivencia de duelos …

Las personas ancianas refieren dificultad para retener informaciones poco significativas, especialmente si deben esforzarse mucho o si en el momento de recibir esa información están realizando alguna otra actividad. También expresan problemas en la organización secuencial de la información recién llegada, así como en la capacidad para sintetizar.

La **memoria a largo plazo,** o memoria remota, parece estar bien conservada: los ancianos recuerdan situaciones y hechos antiguos, son capaces de evocar con detalle hechos que tuvieron lugar en otra época, etapa seguramente significativa en su historia de vida.

La memoria remota les permite recordar y conservar el vocabulario, las experiencias, los recuerdos y mucha información útil sobre el mundo que les rodea y sobre sí mismos. Es importante tener en cuenta que la memoria visual se conserva intacta durante mucho más tiempo que la memoria auditiva o que las relaciones temporo-espaciales.

Resolución de problemas y creatividad.

La dificultad en la organización de la información, la rigidez del pensamiento, la prudencia en la toma de decisiones … pueden condicionar la capacidad para resolver los problemas. El elemento que va a condicionar claramente las respuestas del anciano es el tiempo. La creatividad es difícil de medir, ya que está íntimamente relacionadas con los aspectos cognitivos y afectivos. Las personas mayores pueden descubrir su potencial creativo a través de nuevas experiencias o nuevas actividades.

3.2.2.- MODIFICACIONES EN LA AFECTIVIDAD.

La mayoría de las personas ancianas han adquirido una madurez emocional a través de sus experiencias vitales, lo que les permite responder a situaciones de pérdidas afectivas. Sin embargo, su estado de salud física y mental, así como la calidez u hostilidad del medio en el que viven, influirán en la expresión de su emotividad. Con la edad aumentan las crisis, los problemas, los factores estresantes tienen mayor importancia … y se agravan por las difíciles situaciones de vida que presentan muchas personas ancianas y por la disminución de las fuerzas físicas para hacer frente a esas dificultades.

La motivación.

La motivación representa el **impulso generador de actividades** dirigidas a la satisfacción de un objetivo preciso. No podemos esperar que los mayores ocupen tantas horas del día en realizar actividades como pueden hacerlo personas más jóvenes, pero sí debemos procurar que realicen actividades satisfactorias, que les hagan sentirse útiles y participantes en la sociedad.

La personalidad.

Suele afirmarse que los rasgos de la personalidad del individuo se remarcan con la edad. Cuando hablamos de la **personalidad madura**, hablamos de la personalidad que se mantiene estable. El individuo anciano no suele presentar cambios espectaculares en su personalidad, aunque si realiza ciertos ajustes según las circunstancias vitales. La personalidad se ve afectada por múltiples circunstancias: estado de salud, entorno familiar, pérdidas afectivas, experiencias …

Los análisis de tipologías referidas a personas mayores hacen referencia a la **adaptación al envejecimiento**. Así se identifican personalidades "adaptadas" y personalidades "mal adaptadas".

- Entre las características de la **personalidad adaptada**, están los ancianos realistas, que tratan de vivir esta etapa de su vida de forma satisfactoria, que se mantienen activos e interesados por todo lo que les rodea. Nos podemos encontrar también con personas más pasivas, que están contentos de estar jubilados y de no tener ninguna obligación.
- Entre las segundas, las **mal adaptadas**, identificaríamos a las personas coléricas, negativas y hostiles, que siempre están descontentas, que no aceptan envejecer y que tienen miedo a morir. O aquellos cuyo balance de vida es negativo, se sienten culpables de todo y consideran que la muerte es la única salida a una situación de vida desagradable.

A medida que las personas envejecen se produce una transformación que se ha denominado **interioridad,** que se caracteriza por la pérdida de interés por el mundo exterior. Este cambio se ha definido a partir de dos variables:

- La **energía del yo**, se refiere a la participación enérgica y apasionada en la vida frente a la pasividad. Las investigaciones han determinado que a partir de los 50 años esta fuerza empieza a disminuir y se produce un retraimiento emocional del mundo.
- El **estilo de dominio**, contrapone el dominio activo –mi comportamiento tiene consecuencias- y el dominio pasivo –la realidad viene determinada por el azar, las circunstancias ...-. A partir de los 50 años se produce un mayor estilo de dominio pasivo, e incluso de "dominio mágico" (con un retraimiento más acusado).

Un elemento fundamental para explicar este proceso de "interioridad" es que a partir de cierta edad –en torno a los 60 años- van a ir disminuyendo de forma considerable los papeles que los individuos tienen, fundamentalmente el papel de "padre/madre" (por la ausencia de los hijos de la casa paterna) y el de "trabajador" (por la jubilación). Los individuos ancianos van a pasar mucho tiempo solos y cada vez tienen contactos con menos gente, con lo que se va a ir produciendo un proceso gradual de desconexión.

Estas observaciones van a depender, evidentemente, de la **personalidad individual** y de cómo el anciano vive esta situación de progresiva desconexión de las actividades que hasta entonces habían sido habituales.

Se han desarrollado diversas teorías para explicar la evolución de la personalidad, entre ellas el análisis de **Erikson**, que diferencia entre "**Integridad del yo v/s desesperación".** Constituye la culminación de la resolución triunfante de las siete crisis previas, en el desarrollo a lo largo de la vida, lo que pudo haber sido o por lo que debería haberse hecho en forma distinta. Implica la aceptación de los propios progenitores como personas que hicieron lo mejor que pudieron, haciéndose merecedoras de nuestro amor, aun cuando no fueron perfectas.

También consiste en la aceptación de la cercanía de la propia muerte como fin inevitable de la existencia de la vida. Quien ha fallado al tratar de resolver la crisis "teme desesperadamente a la muerte, expresado en el sentimiento de que el tiempo es ahora corto para volver a comenzar otra vida y buscar caminos alternativos hacia la integridad".

Otra perspectiva diferente es aportada desde la llamada **"teoría de la actividad".** Según ella, cuanto más activa permanezca una persona mayor, más satisfactoriamente envejecerá. Los papeles que constituyen principalmente su satisfacción son: trabajo, matrimonio, paternidad/maternidad. Las máximas pérdidas en esta etapa van a afectar precisamente a estos papeles (jubilación, viudez, enfermedad). Se pueden constituir tres tipos de actividad:

a) Informal: Interacción social con familiares, amistades y vecinos.
b) Formal: Participación de organizaciones voluntarias.
c) Solitaria: Leer, ver televisión y mantener algunos pasatiempos.

La **teoría de la desvinculación** afirma que el envejecimiento se caracteriza por una mutua separación, por parte de la persona mayor, la cual voluntariamente disminuye sus actividades y compromisos. Buen número de estudios afirman que la personalidad permanece estable de una forma muy notoria durante la vida adulta. Estas investigaciones han analizado sobre todo tres rasgos de la personalidad:

1. El neuroticismo: tendencia a la ansiedad, hostilidad, depresión, sufrimiento emocional ...
2. La extraversión: exteriorización, calidez, sociabilidad, afirmación ...
3. La espontaneidad hacia la experiencia: deseos de nuevas experiencias, iniciativa, audacia ...

En general se afirma que hay una cierta estabilidad en los rasgos de la personalidad de los individuos, lo cual no niega la posibilidad de cambios. Siempre existen individuos que cambian mucho más a medida que transcurren los años.

Un aspecto decisivo de nuestra personalidad es nuestra **capacidad para afrontar la vida**. En principio asumimos que las personas con la edad aumentan su capacidad para superar las adversidades y las pérdidas. El aumento relacionado con la edad en las respuestas de dominio pasivo y mágico podría sugerir que la gente cuando envejece afronta la realidad de forma menos madura y prefieren el retraimiento en la fantasía antes que afrontar de forma activa los nuevos desafíos.

Hay situaciones de especial gravedad –la muerte del cónyuge, la inminencia del propio fallecimiento ...- que los ancianos son capaces de afrontar con un estrés normal. Parece ser que esto está relacionado con que se trata de pérdidas "esperadas", son lógicas en ese momento de la vida.

La mayoría de los estudios confirman que hay claras diferencias relacionadas con la edad en los mecanismos de afrontamiento de los individuos, aunque es difícil clasificarlos como formas más maduras o menos. Los acontecimientos preocupantes a los que los individuos se enfrentan en la ancianidad son poco modificables (enfermedades, viudez, etc), con lo que los ancianos tienden a utilizar estrategias más pasivas. Por lo tanto, lo que ocurre es que a medida que cambian las situaciones de estrés, cambian las respuestas para afrontarlas.

Se acepta convencionalmente que la vejez comienza a partir de los 65 años. Es la etapa de la vida en que se acentúa la patología somática. Sin embargo, no debe verse este período como algo uniforme, ya que la salud de nuestros mayores es bastante buena hasta los 75 años y resulta más precaria a partir de esta edad ('old-old').

Los **trastornos psiquiátricos** en la vejez aumentan en relación con otros grupos de edad. Hasta los 75 años lo más frecuente son los trastornos afectivos, y, a partir de esta edad, los fallos cognitivos, las demencias.

Con la edad se producen cambios físicos y psicológicos que pueden influir en la aparición de estas patologías psíquicas. Aparte las variaciones en los diferentes órganos y aparatos, al nivel de sistema nervioso encontramos una disminución del tamaño del cerebro, con agrandamiento de surcos y ventrículos. Se pierden células nerviosas y se produce desarborización de las dendritas. Disminuye el número de sinapsis. Hay cambios degenerativos intraneuronales con placas seniles y haces neurofibrilares, así como depleción de neurotransmisores. Disminuye el flujo cerebral sanguíneo y el metabolismo de la glucosa, no sólo de manera global sino con especial intensidad en determinadas zonas: temporal, frontal, parahipocampal y cíngulo. Se produce depósito de amiloide al nivel de la pared vascular repercutiendo en el flujo.

Los cambios anteriores repercuten en una mayor vulnerabilidad para los enfermos psíquicos o para las agresiones orgánicas.

A nivel de **funciones intelectuales**, la personalidad se hace más rígida, más insegura y egocéntrica. Las personas mayores pueden desarrollar actitudes defensivas, mostrándose hostiles y negativos ante todo lo nuevo. La memoria inmediata o primaria se ve bastante afectada con la edad, y se conserva mejor la memoria secundaria o remota, la más antigua.

3.2.3.- TRASTORNOS PSICOLÓGICOS MÁS FRECUENTES.

Los trastornos afectivos.

Los **trastornos afectivos** son los cuadros psiquiátricos que se presentan con más frecuencia en la primera mitad de este período.

La **depresión mayor** alcanza el 3-5 %. La **depresión menor** y la distimia entre el 10-12 %. El **trastorno**

bipolar (períodos de depresión y de manía) entre el 0,l-0,5 %. En los pacientes institucionalizados de residencias o ingresados en servicios diversos hospitalarios, las proporciones alcanzan hasta el 20-30-40 % de los casos, según los estudios.

Las depresiones en los ancianos presentan una sintomatología similar a la que aparece en otras épocas, con diversos rasgos diferenciales como:

- Los episodios tienden a ser más crónicos y prolongados.
- Se presenta con más asiduidad sintomatología ansiosa y agitación.
- Es más frecuente la sintomatología paranoide.
- Son más comunes los síntomas hipocondríacos y somatizaciones varias.
- Más riesgo de suicido.
- Insomnio más intenso.
- Superior resistencia al tratamiento.
- Disminución importante de los rendimientos cognitivos.

Entre los **factores etiológicos** que favorecen la presentación de los síntomas figuran:

- Las múltiples pérdidas que se producen en esta época: Pérdida de poder y status social, pérdida de salud y seres queridos, pérdida de capacidad económica y disminución de ilusión y proyección hacia el futuro.
- Existen elementos colaboradores como la menor disponibilidad de los neurotransmisores y del número de receptores.
- La presencia de muy diversos tratamientos potencialmente depresógenos como pueden ser los corticoides, antihipertensivos, antiparkinsonianos o antineoplásicos.
- O bien afecciones diversas como endocrinopatías, alteraciones metabólicas o carenciales, carcinomas o infecciones a menudo cursan con depresión asociada.

Estrechamente relacionado con los trastornos afectivos aparece el problema del **suicidio,** más numeroso en este espectro de población, que ofrece una mayor relación de hechos consumados frente a los intentos y con métodos más drásticos. El riesgo mayor, se da en varones, que viven solos, padecen cuadros somáticos dolorosos o enfermedades psíquicas como depresión, alcoholismo y trastornos de ansiedad, o bien si existen intentos previos.

Las demencias.

Las **demencias** son el otro gran cuadro psíquico de la vejez. Es un síndrome debido a una enfermedad del cerebro, generalmente de manera crónica y progresiva, con déficits de múltiples funciones corticales superiores, entre ellas la memoria, el pensamiento, la orientación, la comprensión, el cálculo, la capacidad de aprendizaje, el lenguaje y el juicio.

La prevalencia de la enfermedad sería aproximadamente del 1-2 % de las personas de 65 años, y se duplicaría cada 5 años hasta los 85-90, a partir de lo cual progresaría de manera más lenta.

En nuestro país, la forma más frecuente es **la demencia degenerativa de Alzheimer,** 55-60 % de los casos y después la **demencia vascular,** 10-20 % del total; la demencia mixta representa el 10 % aproximadamente. En otros países como Japón, China o Rusia prevalece la forma vascular. La **demencia con cuerpos de Lewy** difusos alcanzaría hasta un 10-20% del total, pero erróneamente se incluye, a menudo, dentro del Alzheimer.

Se diferenciaría por la frecuencia con que aparecen síntomas psicóticos, la mala tolerancia a los

neurolépticos, la presencia de síntomas extrapiramidales, y por las pérdidas de conciencia y caídas inexplicables. También se piensa que son más frecuentes de lo que se creía las **demencias frontotemporales,** con abundante sintomatología de tipo psíquico: aplanamiento afectivo, disforia, desinhibición, conductas inadecuadas o impulsividad, según predomine el síndrome orbitofrontal o el dorsal medio. El resto de las demencias se repartirían entre las debidas a causas infecciosas: HIV o sífilis, las postraumáticas y las debidas a factores carenciales.

Ante un cuadro de demencia, no sólo se debe identificarlo como tal, sino averiguar a qué tipo de demencia corresponde: vascular, Alzheimer, etc., y, sobre todo, diferenciar el grupo reducido (5-10 % del total) de demencias, parcial o totalmente reversibles, para instaurar el tratamiento "ad hoc" a la mayor brevedad. Las causas más frecuentes son el hipotiroidismo, la hidrocefalia de presión normal, la sífilis y los déficits de vitamina B12 y ácido fólico.

La pseudodemencia.

La pseudodemencia es un síndrome, no un diagnóstico. Se llama así a un cuadro clínico que semeja una demencia, pero que es producido por un **trastorno psíquico funcional** y no a una causa neurológica. Es reversible. Puede ser provocado por diversos procesos: esquizofrenia, trastorno ficticio, neurosis postraumática, manía, etc., pero su causa más frecuente es la depresión.

El delirium o estado confusional agudo.

El **delirium o estado confusional agudo** es frecuente en el domicilio y, sobre todo, en unidades de hospitalización. A veces quedan sin diagnosticar. Se caracteriza por una presentación aguda o subaguda de alteración del nivel de conciencia, alteración de memoria y pensamiento, desorientación, alucinaciones o ideas delirantes, y agitación psicomotriz. Lo provoca alguna causa médica y presenta gran variabilidad en la sintomatología, con empeoramiento nocturno.

El cerebro del anciano, con sus déficits ya descritos, es especialmente sensible a cualquier factor psíquico (cambio de residencia, privación sensorial) o físico (infecciones, tratamientos, desequilibrios electrolíticos o anestesia).

En el tratamiento, aparte de sedar al paciente si está agitado y atacar la causa somática provocadora, resulta fundamental mantenerle en un medio tranquilo, sosegado, con personas conocidas, darle puntos de referencia y orientación, y protegerle de los riesgos de auto-heteroagresión facilitados por la confusión.

Los trastornos delirantes.

Los **trastornos delirantes** pueden ser primarios o secundarios a tratamientos diversos o causas orgánicas. Encontramos ideación paranoide en el 2-4 % de los ancianos y actitudes de desconfianza, sin cristalizar en un delirio, en proporción mucho mayor. También se presentan casos de esquizofrenias antiguas que alcanzan esta edad y en las que van a predominar los síntomas negativos y defectuales frente a los positivos.

Los trastornos delirantes en los ancianos se ven favorecidos por el aislamiento, los déficits sensoriales (vista u oído) , los fallos cognitivos, el agotamiento y las enfermedades somáticas o tratamientos concomitantes. El tratamiento preferente es con neurolépticos, eligiéndolos según el perfil de efectos indeseables, y recordando la peor tolerancia de los ancianos a los efectos secundarios anticolinérgicos o hipotensores.

Las alteraciones del sueño.

Las **alteraciones del sueño** son frecuentes. Hasta en un 10-20 % de los ancianos se producen alteraciones del sueño, que generan un número elevado de consultas médicas. El insomnio, junto con la incontinencia y la agitación psicomotriz, son los principales síntomas. Además, acompaña a casi todos los trastornos psíquicos. Suelen tener una etiología multifactorial, en la que se mezclan causas somáticas y psíquicas, malos hábitos higiénicos, consumo de alcohol o café. El insomnio precoz va asociado a preocupaciones recientes o consumo de estimulantes. El insomnio medio se asocia sobre todo con procesos dolorosos, síndromes de piernas inquietas o patología respiratoria. El insomnio tardío o despertar precoz es típico de la depresión mayor. Al instaurar el tratamiento, debe tenerse en cuenta la vida media del fármaco, eligiendo aquellos de vida media o intermedia para evitar que éste mantenga sus efectos durante el día.

Los trastornos de ansiedad.

La **ansiedad** es un síntoma frecuente en el anciano. Las manifestaciones, a nivel psicológico y somático, van a ser muy similares a las de otras épocas de la vida. La prevalencia es del 6-10 % para los trastornos de ansiedad en general, siendo la más frecuente la fobia (4,5-5 %) sobre todo la agorafobia, y también los trastornos adaptativos ansiosos. No son frecuentes las crisis de pánico (0,5-1 %) ni los trastornos obsesivo-compulsivos. Existen cuadros de ansiedad secundaria a fármacos, al padecimiento de enfermedades somáticas sobre todo endocrinopatías, problemas cardiorespiratorios, o síntomas de ansiedad secundaria a situaciones de estrés. En la vejez se acumulan situaciones de estrés y su capacidad de adaptación se encuentra disminuida. Aparecen después de acontecimientos traumáticos. Pueden presentar síntomas disociativos o somatizaciones diversas.

3.3.- ASPECTOS SOCIALES DEL ENVEJECIMIENTO.

El papel del anciano en la sociedad actual (especialmente en los países desarrollados) está en un **cambio constante**. Por un lado, parece quedar relegado por una visión economicista de la vida. Por otro lado, esta misma visión confirma que se crean nuevos problemas que hay que intentar resolver con nuevas fórmulas. En las antiguas civilizaciones el papel del anciano era muy importante: era respetado, sus consejos se valoraban y se seguían, y eran un elemento clave para el buen funcionamiento de la sociedad. Se pensaba, con lógica aplastante, que "el que más vive más sabe." Pero los tiempos cambian. De hecho, en la sociedad moderna, llena de adelantos tecnológicos, se valora más la productividad y la utilidad inmediata que la experiencia acumulada durante años. Se piensa muchas veces que el anciano no ha sido capaz de entender estos nuevos avances tecnológicos. Y por eso se va relegando a un lado a las personas mayores y se piensa que existen muchas cosas que no pueden hacer.

La idea de nuestra moderna sociedad sobre la vejez es **negativa.** En ocasiones parece que la persona mayor se convierte en un “enemigo público”. Sólo se piensa en lo negativo: dependen de sus familias, tienen menor poder adquisitivo, producen un mayor gasto sanitario y en pensiones ... Es curioso que esa misma sociedad no piense que esas personas mayores han dedicado sus mejores años a criar a sus hijos, a trabajar para que el país tenga un mayor desarrollo, etc. Y de hecho, es una visión falsa, ya que los mayores aportan aún mucho a la sociedad.

Es importante por nuestro propio interés cambiar la idea de vejez. Los jubilados actuales tienen todavía mucha capacidad de aportar elementos valiosos a la sociedad en la que viven. Además, si se integran en la comunidad la dependencia y la enfermedad, tardaran más en llegar.

3.3.1.- LA GERONTOLOGÍA Y LA GERONTOLOGÍA SOCIAL.

La **gerontología** (de *geronto*, anciano y *logos*, estudio) es el área de conocimiento que estudia la vejez y el envejecimiento. A diferencia de la **geriatría** -rama de la medicina que se centra en las patologías asociadas a la vejez, y el tratamiento de las mismas-, la gerontología se ocupa, en el área de salud, estrictamente de aspectos de **promoción de salud**. Por lo demás, aborda aspectos psicológicos, sociales, económicos, demográficos y otros relacionados con el adulto mayor.

Diversos factores explican el reciente desarrollo de este tipo de preocupaciones. En primer lugar, la incrementada importancia que ha tomado el envejecimiento de la población. A ello se suman las condiciones de vida actuales de las personas mayores que, a diferencia de lo que ocurría anteriormente, lo más corriente es que ya no conserven unos vínculos familiares tan estrechos con su familia; de este aislamiento resulta la necesidad de preocuparse por su autonomía económica y por los diferentes problemas vinculados al estado de creciente soledad en la edad en la que se encuentran.

La gerontología tiene un doble objetivo:

- Desde un punto de vista cuantitativo, la **prolongación de la vida** (dar más años a la vida, retardar la muerte), y

- Desde un punto de vista cualitativo, la **mejora de la calidad de vida** de las personas mayores (dar más vida a los años).

La gerontología es un estudio multidisciplinar porque, como toda nueva área de conocimiento, se ha nutrido y nutre del conocimiento aportados por otras. Así, la biología, la sociología, la psicología, la antropología, la demografía, la educación y otros campos del saber vierten su cuota de participación para hacer de la gerontología una realidad como campo de conocimiento independiente: La gerontología incide en la calidad y condiciones de vida del adulto mayor mediante el diseño, ejecución y seguimiento a políticas y programas destinados al beneficio de la población anciana. De esta forma suma vida a los años más que años a la vida; este último sería un objetivo de la geriatría.

La **Gerontología Social** estudia el lugar y la participación del adulto mayor en sociedad y cómo esta afecta el proceso de envejecimiento. Al respecto, el profesional de la gerontología social debe tener en su haber académico materias como sociología del envejecimiento, **trabajo social**, estadística, musicoterapia, psicogerontología. Este profesional enfatiza en su práctica en aspectos de recreación, evaluación de las actividades diarias del adulto mayor, políticas de inserción en los diversos estratos sociales.

Teniendo como principal objetivo el **mantenimiento del anciano dentro del seno familiar**, su entorno se constituye como el espacio más adecuado de cuidados preventivos y apoyo para la mejor calidad de vida en las edades tardías. Sin embargo, no siempre los familiares están en condiciones de proveer al mayor de estos cuidados. De allí que el proceso de institucionalización, es decir, el ingreso en asilos, unidades geriátricas o gerontogeriátricas, unidades de larga estancia, entre otros; se presenta como una alternativa.

La gerontología social es la rama de la gerontología que se encarga del **desarrollo de la investigación sobre las diversas problemáticas sociales relacionadas con la vejez**, así como del **diseño y aplicación de acciones tendentes a lograr el bienestar del anciano en el contexto social** incidiendo sobre aspectos económicos, protección social, vivienda, educación para la vejez, interacción anciano familiar-comunidad e institucionalización, entre otros. Tiene dos componentes esenciales: investigación y trabajo comunitario, con acentuado énfasis en el área preventiva. La investigación es teórica y diagnóstica, aporta elementos a la práctica gerontológica social, que se canaliza a través del diseño y la aplicación de políticas y programas. Los resultados obtenidos en la evaluación y seguimiento a la práctica vuelven a nutrir al cuerpo de investigación, que obtiene así nuevos elementos de estudio. Se forma así un circuito de conocimiento que enlaza en forma permanente la teoría y la práctica gerontológica.

3.3.2.- IMAGEN SOCIAL DE LOS ANCIANOS.

Numerosas revisiones de la literatura sobre las **actitudes hacia las personas mayores** señalan que hay un predominio de ideas negativas, tanto sobre el envejecimiento como sobre las personas mayores, y que estas actitudes negativas se dan en todas las edades, niveles educativos, situaciones geográficas, ocupaciones o clases sociales. Los análisis realizados diferencian tres grupos de actitudes en relación a esta realidad:

- **Actitudes de los jóvenes hacia los mayores:** las actitudes revisten generalmente apreciaciones negativas. A mayor edad se dan actitudes más positivas hacia los ancianos; en general, los más jóvenes presentan actitudes más negativas.
- **Actitudes de los mayores hacia los jóvenes:** los mayores suelen tener actitudes negativas frente a la juventud (irresponsables, vagos, problemáticos …). Se dan diferencias dependiendo de diversos factores: a más edad, actitudes más negativas; los hombres suelen tener actitudes más negativas; a mayor nivel cultural, las actitudes son más positivas …
- **Actitudes de los mayores hacia los mayores:** también utilizan los estereotipos que refiere la población en general.

Desde estos estudios es frecuente que la visión sobre los ancianos esté cargada de **estereotipos**. **Lehr** enuncia **seis estereotipos**: las personas mayores son viejos, la mayoría de las personas mayores tienen mala salud, el rendimiento intelectual en los ancianos no es comparable al de los jóvenes, las personas mayores son improductivas, las personas mayores no son ni se sienten atractivas, todos los ancianos son iguales. **McTavsih** enumera los estereotipos resultantes de sus investigaciones: enfermo, cansado, desinteresado por el sexo, mentalmente lento, olvidadizo, menos capaz de aprender cosas nuevas, malhumorado, apartado, improductivo, defensivo … Estos autores, igualmente afirman que las actitudes hacia la vejez no son consistentemente negativas y que, frecuentemente, están relacionadas con otras variables (como la educación). Igualmente, los estereotipos tienden a desaparecer cuando se producen encuentros con personas mayores concretas y conocidas.

Los cambios sociales que se producen durante el envejecimiento se refieren principalmente al cambio del rol del anciano, tanto en el ámbito individual como en el de la propia comunidad. Asimismo, es importante considerar las diferencias generacionales existentes a nivel de comportamiento social y las dificultades de adaptación e integración que suele presentar el anciano ante estos cambios.

No todos los ancianos –como venimos recogiendo- viven de la misma manera esta etapa del desarrollo vital, ya que van a estar muy ligadas a la vivencia del propio envejecimiento y a la capacidad para aceptarlo y adaptarse al mismo.

3.3.3.- EL CAMBIO EN EL ROL INDIVIDUAL.

Aunque los límites de la extensión del rol individual son difíciles de medir, a grandes rasgos se plantean cambios en tres dimensiones:

- Como **individuo único,** capaz de decidir, con opiniones, creencias y valores propios, con una historia personal, con una concepción de la vida y de la muerte.
- Como **integrante de un grupo familiar**, sus relaciones con el grupo y el relevo de su papel en el seno de la familia.
- Como persona receptora y dadora de afecto, **capaz de afrontar las pérdidas**.

El anciano como individuo único.

En la última etapa de la vida se hace patente la conciencia de que la muerte está más cerca y es previsible que ocurra en un futuro más o menos inmediato. La concepción de la vida y la muerte adquieren en este momento un nuevo sentido. La respuesta individual del anciano frente a la vida y la muerte está condicionada por una serie de factores: creencias religiosas, cultura, factores educacionales, las propias experiencias sobre la muerte vividas a lo largo de su existencia, el estado en que se encuentre …

El temor y la angustia que rodean a la muerte, y que el anciano suele verbalizar frecuentemente, están ligados a la imagen que cada individuo tiene de este suceso, siendo la soledad, la oscuridad, el sufrimiento, el dolor … los componentes que más le preocupan.

La ancianidad –como ya hemos señalado al hablar de la personalidad- es el momento en que las personas necesitan asumir, reasumir su existencia pasada y efectuar una relectura de su vida. Remover los recuerdos no es siempre experimentar nostalgia o amargura, puede ser también un momento de reconciliación con la vida pasada, de apreciar sus momentos positivos, de asumir –también con la distancia- las pérdidas y las desgracias.

El anciano como integrante de un grupo familiar.

El envejecimiento transforma el rol del anciano en el seno familiar. Las relaciones familiares cambian. El anciano no suele vivir con sus hijos y nietos, ya que ni las características de la estructura familiar ni las condiciones de espacio en las viviendas lo facilitan. Este fenómeno es más habitual en las zonas urbanas que en las zonas rurales.

Las relaciones con los hijos y nietos pasan –normalmente- por dos etapas diferentes:

- Cuando el anciano es independiente y no tiene problemas de salud, es una ayuda para la familia, participa en las tareas del hogar y se encarga del cuidado de los nietos, con los que puede establecer relaciones de complicidad.
- En el momento en que aparecen problemas de salud y de dependencia, las relaciones suelen invertirse: el anciano pasa de proporcionar ayuda a recibirla, de cuidar a ser cuidado, perdiendo peso específico dentro de la familia. Esta situación le puede generar sentimientos de rechazo, inutilidad, abandono.

El anciano como persona capaz de afrontar las pérdidas.

La ancianidad es una etapa de la vida caracterizada fundamentalmente por las pérdidas (pérdida de facultades físicas, pérdidas afectivas, pérdidas económicas …). Todas estas pérdidas van acompañadas de una serie de sentimientos como tristeza, pesar o dolor, y de una serie de reacciones tanto emotivas como de comportamiento de duelo. La pérdida afectiva, especialmente relacionada con el cónyuge, es la que adquiere mayor trascendencia.

Las pérdidas afectivas van acompañadas de una gran tensión emocional y de un sentimiento de soledad. El anciano pasa por períodos de pena y de dolor, y por períodos de remordimiento alternativamente unidos a reacciones de cólera, tanto dirigidas al desaparecido por haberlo abandonado, como a las personas que le rodean para desplazar sus sentimientos y su frustración. Estas pérdidas acarrean, en general, grandes cambios en su vida cotidiana: cambios de domicilio, nuevas responsabilidades …

De estas vivencias, la consecuencia que ocasiona más problemas es la soledad. Este sentimiento es muy difícil de superar. Por ello, algunos ancianos deciden formar nuevas parejas, ya que las necesidades emocionales precisan la misma atención que en otras etapas de la vida.

La viudez.

La pérdida del cónyuge es un acontecimiento predecible en la vejez, sobre todo más probable en el caso de las mujeres ya que su esperanza de vida es superior a la de los hombres y además existe la tendencia a contraer matrimonio con hombres de mayor edad.

El hecho de la viudez significa la dolorosa pérdida del compañero/a en la vida. Supone un cambio radical en la vida cotidiana. Los individuos que acaban de quedarse viudos deben cambiar su esquema global sobre la realidad, rehacer su identidad.

El duelo normal.

El duelo por la pérdida de alguien querido presenta un curso predecible. Hay un primer momento de aturdimiento: oleadas de añoranza y anhelo intenso se entremezclan con depresión y apatía. Posteriormente llegan fases de nostalgia y de búsqueda, después una fase de desorganización y desesperación y, por último, una fase de recuperación.

Para recuperarse de este suceso traumático la persona viuda debe alcanzar ciertos puntos de referencia, son las denominadas "actividades del duelo":

1. **Aceptar la realidad de la muerte**: tras el fallecimiento existe la sensación de que éste no ha ocurrido. El individuo que se ha quedado viudo puede aceptarlo desde un punto de vista intelectual, pero siente que en cualquier momento se despertará de un mal sueño. La primera tarea del duelo es aceptar el hecho real de la muerte.
2. **Experimentación del pesar**: es necesario aceptar emocionalmente la realidad de la muerte, afrontando los sentimientos de pérdida con una aflicción profunda y abierta.
3. **Adaptación a la nueva vida**: la persona debe aprender a desenvolverse en áreas y ámbitos cuya responsabilidad incumbía al cónyuge o en espacios donde siempre se había vivido como pareja. Debe tratar de estructurar, en último término, una vida estable y relativamente satisfactoria.
4. **Ser capaz de establecer relaciones afectivas**: es importante recuperar la capacidad de sentir afecto en su sentido más amplio, volver a preocuparse por la vida y por otras personas.

El duelo patológico.

No es fácil precisar el tiempo de elaboración del duelo y a partir de qué momento se produce el duelo patológico o duelo crónico. Existen individuos que experimentan reacciones de duelo muy prolongadas y excesivamente dolorosas. Existen muchos factores que pueden afectar la profundidad del duelo y la facilidad de recuperación. Entre ellos destacamos:

- La influencia de la propia personalidad.
- La pérdida de seres queridos en la infancia o en momentos significativos de la vida.
- La existencia de otras relaciones familiares o sociales que puedan aminorar la pérdida.
- El grado de dependencia respecto de la pareja.
- Enfermedades mentales previas (por ejemplo, depresión).

3.3.4.- CAMBIOS DE ROL EN LA COMUNIDAD.

La contribución individual del hombre al grupo de pertenencia puede tener amplias perspectivas; sin embargo, la sociedad en general valora tan sólo al hombre activo, al que aporta trabajo y genera riqueza. La dimensión del papel del individuo dentro de la comunidad gira en torno a dos ejes fundamentales: la actividad laboral y la actividad social, caracterizadas por la participación en las tareas comunitarias.

El hecho de envejecer modifica el rol que se ha desarrollado, pero no de forma individual, sino en el momento que la sociedad lo incluye dentro del grupo de ancianos, aproximadamente a los 65 años.

Rol social.

Los cambios sociales producen en el anciano la sensación de no pertenencia al grupo escogido, al tiempo que el joven no es capaz de integrarlo en sus grupos. Las costumbres, el estilo de vida y la concepción de la propia existencia separan las generaciones e inciden negativamente en el mutuo reconocimiento de los individuos que las componen.

Como consecuencia de este rechazo, se da la proliferación de grupos paralelos formados únicamente por ancianos, lo que provoca un mayor distanciamiento intergeneracional.

La jubilación.

En el rol laboral, el gran cambio viene dado por el momento de la jubilación. Esta nueva situación comporta para el anciano, en ocasiones, una serie de consecuencias negativas que es necesario analizar para poder evitarlas.

La jubilación es la situación de una persona que tiene derecho a una remuneración o pensión, después de haber cesado total o parcialmente en su profesión u oficio.

En todos los países se ha dado prioridad a lo económico, sin tener en cuenta los aspectos físicos, psicológicos y sociales que comporta el hecho de la jubilación, ni tampoco el difícil proceso de adaptación por el que pasan algunas personas. La adaptación es difícil porque la vida social y sus valores están orientados en torno a la actividad y al trabajo que se realiza, de modo que estos proporcionan y condicionan, en la mayoría de las ocasiones, la personalidad, las relaciones y el rol social. Esta pérdida de rol lleva consigo una serie de consecuencias que repercuten en la situación económica e incluso en la salud física y psíquica.

Las relaciones sociales se reducen de forma importante al abandonar la actividad laboral, los recursos económicos disminuyen en la mayoría de los casos, siendo en general insuficientes; el exceso de tiempo libre exige una reorganización de la vida cotidiana y una utilización de los recursos personales y culturales para evitar la angustia. Esta etapa coincide con la pérdida de seres queridos y con el "nido vacío", la marcha de los hijos del hogar para crear su propia familia.

En relación a la jubilación, se han descrito tres rupturas fundamentales:

- La primera, la constituye la desvalorización que supone el cese del trabajo como una situación de crisis de identidad social y de personalidad.
- La segunda, el contar con un excesivo tiempo libre que en muchos casos es difícil de emplear.
- La tercera, la ausencia de socialización en esta nueva etapa.

En esta línea también se han descrito repercusiones sobre la salud, como perturbaciones emocionales, estados depresivos y de ansiedad, trastornos del sueño, manifestaciones hipocondríacas que pueden influir en la aparición de otro tipo de enfermedades …

Por el contrario, otras teorías mantienen que el empleo del tiempo libre en la jubilación puede constituir una fuente de satisfacciones personales que evitan que se produzca esta situación de crisis y falta de identidad.

Ante las consecuencias descritas anteriormente, en algunos países desarrollados se están realizando programas de preparación para la jubilación. Los objetivos básicos de estos cursos deben ser:

- Como proyectar el futuro financiero.
- Como ocupar el tiempo libre.
- El conocimiento de las alteraciones y/o problemas de salud que se pueden presentar con la edad.

En general los individuos que gozan de una buena salud y que no van a pasar apuros económicos están preparados para adaptarse positivamente a la jubilación. Igualmente parece que los individuos con una educación superior, casados y comprometidos en actividades extralaborales tienen menos dificultades para adaptarse a la jubilación.

Por el contrario, los individuos desdichados y mal adaptados tienen más posibilidades de ser jubilados infelices y mal adaptados.

Se han definido cinco tipos de personalidad respecto a su adaptación a la jubilación:

1. El "individuo maduro": visión del mundo y de la vida realista, se siente realizado y vive como algo normal el hecho de envejecer. Acepta positivamente el hecho de la jubilación.
2. El "individuo sentado en una mecedora": elude las responsabilidades, prefiere quedar en un segundo plano. La jubilación le permite satisfacer esa necesidad.
3. El "individuo acorazado": necesita estar siempre ocupado. La idea de la jubilación genera en él mucha ansiedad. Su jubilación será feliz si es capaz de llenar el tiempo con actividades.
4. El "individuo enojado": se considera un fracaso, y el mundo tiene la culpa de todo. Malas expectativas respecto a su jubilación.
5. El "individuo que se aborrece": no está conforme con cómo se ha desarrollado su vida, se culpa de ello.

4.- NUEVOS ROLES DE LA PERSONA MAYOR EN NUESTRA SOCIEDAD.

El envejecimiento concebido como un proceso que experimentan los individuos puede ser visto desde dos enfoques, uno biológico y otro social. Para algunos autores la vejez es un "destino social", puesto que son las características de la sociedad las que condicionan tanto la cantidad, como la calidad de vida.

La sociedad actual ensalza la juventud por su relación con la belleza y la salud, y ve como algo negativo el envejecimiento. La sociedad crea sus propios estereotipos, muchos de ellos hacen referencia a las personas mayores: son todos muy parecidos, están deprimidos, son dependientes, aislados socialmente, de difícil trato, incapaces de nuevos aprendizajes …

Hay que reconocer que los ancianos no siempre son dependientes a causa de su decadencia física, sino que lo son frecuentemente debido a la forma cómo son categorizados socialmente y a las presiones que se ejercen sobre ellos. Si bien es cierto que el envejecer implica un deterioro biológico, son las condiciones sociales, en buena medida, y las ideas contenidas en el modelo tradicional las que restan oportunidades para que el anciano se mantenga activo y autónomo. La carencia de una definición sociocultural del conjunto de actividades que serían específicas de los ancianos les hace sentirse inútiles y sin reconocimiento social. La falta de tareas específicas conlleva la dificultad para saber en qué concentrar los esfuerzos y en qué volcarse de modo de actualizar las propias potencialidades. Cada individuo que envejece debe crearse un personaje e improvisar su actuación: la dificultad de esto implica que sólo algunos lo logran y otros deben resignarse al estrecho mundo de las cuatro paredes del hogar.

El aumento progresivo de las expectativas de vida en todas las sociedades presenta para los próximos decenios el importante desafío de definir el significado y los roles sociales de los adultos mayores. Este desafío implica la necesidad de realizar arreglos sociales que permitan a las personas mayores el desarrollo de todas sus potencialidades en busca de un envejecimiento exitoso. Un envejecimiento exitoso y saludable tiene que ver con la funcionalidad biológica y social que permite la plena integración social y familiar de los que envejecen, lo que implicará superar las barreras sociales y culturales que aún persisten e impiden a los adultos mayores desarrollar sus potencialidades.

En las modificaciones que deban realizarse están involucrados el estado, las organizaciones sociales, la comunidad, la familia y cada uno de los individuos.

Aun cuando la gran mayoría de las personas adultas mayores son relativamente independientes y físicamente aptas y funcionales, el grupo de los mayores de 80 son más dependientes, más aún si su nivel socioeconómico y estado de salud son limitados. La O.M.S. ha definido la salud del anciano por su capacidad para funcionar, y no por las limitaciones, discapacidad o enfermedad que presente.

Así, la calidad de vida de las personas mayores está estrechamente relacionada con la capacidad funcional y el conjunto de condiciones que le permiten mantener su participación en su propio autocuidado y en la vida familiar y social.

La interacción de los factores biológicos con la psicología del comportamiento y con los procesos sociológicos del envejecimiento aparece con frecuencia en los estudios realizados a la fecha. La posibilidad de controlar una enfermedad está condicionada por la aptitud social para integrar a la persona enferma a un sistema de vida que le ayude a resolver sus problemas ambientales y particularmente la aptitud para desenvolverse en la actualidad. De igual forma, la capacidad social para integrarse varía según el individuo que envejece. La tendencia a favor de una vejez activa procura que el anciano conserve su independencia, su libertad de acción y su iniciativa, de manera que sea capaz de elegir el mayor número de opciones en su vida, sin desconocer la realidad de que la gente de mayor edad es menos capaz de ejercer su independencia, tiene menos eficiencia en su trabajo y es más vulnerable a las enfermedades.

La persona mayor ha de tomar una actitud positiva en la vida y la primera de estas actitudes básicas es aprender a ser uno mismo, aprender a saber vivir consigo mismo, a conocerse tal y como uno es, con sus dimensiones reales, espaciales, temporales, corporales …

Es preciso tender a una **reconceptualización y revalorización de la edad adulta tardía** como una etapa normal de la vida del ser humano, con sus características propias y definidas y que llevan inmersa la posibilidad de prepararse para la vejez. Esto implica esencialmente, y a modo de síntesis, asumir y resolver la aceptación de la edad, una redefinición de roles, la búsqueda e identificación de formas alternativas para el cese de ingresos y, la revisión de vida y establecimiento de nuevas metas. Así, el "funcionamiento" de una persona en sociedad es factible de medir a través de su desempeño, en los distintos roles sociales que le corresponde ejecutar El concepto de **rol social** ha sido definido de diferentes maneras. Podemos entenderlo como un conjunto de expectativas que las personas tienen acerca de la conducta de una persona, quien toma o adopta una posición determinada. Se puede precisar que el papel que una persona desempeña en sociedad está influido por las nociones propias y expectativas acerca de cómo debe comportarse; las nociones y expectativas de otros relevantes, la norma del grupo o de la población; las sanciones positivas o negativas que imponen otras personas (y posiblemente el mismo individuo), cuando el rol de conducta relevante se encuentra en discusión.

Las personas mayores constituyen un importante capital activo para nuestra sociedad. Calidad de vida y envejecimiento activo son conceptos que deben concretarse en objetivos y acciones concretas, más allá de las declaraciones de principios más o menos teóricas.

El Plan de Acción Internacional sobre el Envejecimiento, las recomendaciones del Foro Mundial de ONGs, las conclusiones del Foro Científico de Valencia, las Recomendaciones de la Conferencia de Berlín sobre el envejecimiento, las recomendaciones de las OMS en su documento "Salud y Envejecimiento" y las conclusiones de los Consejos de Personas Mayores coinciden en destacar la **función social del envejecimiento activo** y la necesidad de indagar en el concepto y diseñar políticas que lo promuevan considerando siempre el valor de la participación, la contribución de las personas mayores y su derecho a no ser discriminadas por causa de su edad, género o grado de vulnerabilidad.

El Ayuntamiento de Madrid, desarrollando el Plan de Madrid Ciudad Amigable con las Personas Mayores, ha elaborado diversos documentos para **fomentar una imagen adecuada del envejecimiento**. Los **principios rectores** que posibilitaran esa sensibilización social necesaria están relacionados con el reconocimiento de los derechos, la individualidad, la diversidad y el reconocimiento, la sabiduría, la cooperación o participación, el rol productivo, la autonomía, la confidencialidad, la imagen, la comunicación, la dignidad, la intimidad, la seguridad y también la equidad.

EL EDADISMO.

El **edadismo** se manifiesta en todas las relaciones en el ámbito social, tanto en la esfera de lo privado como de lo público. En relación a las esferas públicas o de ciudadanía, las personas mayores participan en numerosas interacciones cotidianamente en las que este edadismo está presente con muchísima frecuencia. El termino edadismo (ageism) fue acuñado en 1969 por el médico y gerontólogo **Robert N. Butler.** Butler se refiere al edadismo (la siguiente forma más importante de discriminación después del racismo y el sexismo) para evidenciar el **conjunto de actitudes, creencias, estereotipos, prácticas individuales e institucionales discriminatorias y negativas hacia las personas de más edad**. Sin embargo, este concepto no comienza verdaderamente a expandirse hasta el Plan Internacional de Acción de las Naciones Unidas (en abril de 2002) en el cual se sitúa el maltrato hacia las personas mayores como una violación de los Derechos Humanos Universales. En el contexto del maltrato, el edadismo cobra fuerza pasando muy poco a poco de ser una realidad invisibilizada a irse poniendo en los foros científico/profesionales y más tarde, en las agendas políticas.

Las personas mayores de Madrid utilizan muy frecuentemente servicios públicos de diverso tipo: sociales, culturales, sanitarios, de transporte... cómo son percibidos los vecinos de más edad por parte de las personas con las que tienen trato o relación de cualquier tipo (comercial, asistencial, etc.) influye de forma importante en el trato que se les dispensa. Pero, además, el edadismo se construye también y reproduce por medio del lenguaje que se utiliza en esta comunicación, así como también, en la calidad y la cantidad de información que se ofrece. Esta forma de relación y comunicación establece un rol en el que al ciudadano de mayor edad se le permite o no tener un papel activo, seguir controlando y decidiendo sobre su propia vida, continuar ejerciendo sus derechos como cualquier otro vecino de Madrid.

De la revisión documental realizada se extrajeron los principales temas relacionados con esta forma de discriminación por edad. Estos han sido el eje del **decálogo** realizado:

- Cómo se conciben los **derechos de las personas más mayores** y qué modo de actuar tenemos los profesionales para facilitar que puedan ejercerlos.
- El edadismo parte de una visión que minusvalora a los sujetos por el hecho de envejecer, y se aplica una idea única a todos. Es decir, se olvida la idea de **individualidad, el reconocimiento a la diversidad y el reconocimiento de cada sujeto**.
- Otra percepción errónea e injusta se refiere a la falta de reconocimiento al conocimiento y a los saberes de las personas de más edad. Es necesario, por tanto, **revalorizar la sabiduría** de los ciudadanos más mayores.
- La idea de que las personas cuando tienen mucha edad no están interesadas en **cooperar o en participar en los asuntos de su vida, de su barrio**, de su ciudad es otro prejuicio a desterrar.
- Cualquier persona, de cualquier edad o situación de diversidad, necesita poder desarrollar un **rol productivo** pudiendo hacer cosas que le sean valiosas para sí mismo y para el resto de la sociedad. El edadismo presupone que los más mayores ya no pueden hacer tareas o roles de valor.
- La I**nformación** es un elemento imprescindible para desempeñar un rol adulto y la **autonomía decisoria** es un rasgo y derecho que hay que proteger. El edadismo minimiza la necesidad que tienen los adultos mayores de ambos derechos y ello no es admisible.
- Pensar que no es necesario guardar la **confidencialidad** es otra idea errónea de quienes piensan que los ciudadanos de más edad no tienen nada que puedan reservarse para ellos mismos, o consideran que al tratarse de profesionales pueden gestionar la información referida a ellos sin mayor cuidado. Esto es otra evidencia de discriminación.
- La **imagen social de la vejez** y de las personas que llegan a ella puede favorecer el respeto a la diversidad o, por el contrario, el estereotipo y el estigma. Es necesario repensar la imagen que se transmite para ver qué valores reproduce.

- Un trato excesivamente familiar, una **comunicación inadecuada** expresa la falta de respeto y consideración hacia el sujeto. La edad no ha de interferir en el estilo de trato y comunicación.
- A medida que se envejece, y sobre todo en edades muy avanzadas, es frecuente encontrar **personas en situación de gran vulnerabilidad**, sea esta física, cognitiva, social, afectiva u de otro tipo. Tener **necesidad de apoyos y ayuda** no es condición que justifique la discriminación. La **dignidad de la persona** ha de demostrarse expresamente en estas fases de la vida.
- Considerar la **intimidad** como algo importante para la persona es un eje transversal de nuestra cultura, que no debe verse interrumpido con el pasar del tiempo. El edadismo tiende a considerar que no hay que cuidar el derecho a la intimidad de las personas mayores, lo que evidencia otro rasgo de desprecio hacia la persona.
- Todos necesitamos **seguridad**. Es necesario construir lazos de corresponsabilidad y solidaridad que generen una sociedad que la proporcione a los ciudadanos que en cada momento la necesiten, pero eso sí, siempre desde el máximo respeto.
- Dar a cada uno lo que precisa, personalizar en las respuestas a cada persona es la base de una sociedad justa. Hablar de **equidad** es también poner límites al edadismo. Es más, la discriminación por edad justifica la inequidad.

5.- POLÍTICAS DE ENVEJECIMIENTO ACTIVO.

5.1.- DEFINICIÓN DE ENVEJECIMIENTO ACTIVO.

Las personas envejecen como han vivido y llegan a la vejez marcadas por un importante bagaje de acontecimientos vitales. El envejecimiento activo es un **proceso dinámico**, no un estado al que se llega de forma pasiva.

Nos encontramos en un momento histórico singular en relación con el envejecimiento. Las personas no sólo desean y logran vivir más años, sino que aspiran a llenarlos de vida haciendo bueno el lema de las políticas sociales de dar más años a la vida, pero también más vida a los años, independientemente del nivel de dependencia o vulnerabilidad de la persona, de su género o de su edad.

El concepto de envejecimiento activo tiene su origen en los **años 60**, cuando nació la teoría de la actividad (Havighurst y Albretch, 1.963) según la cual permanecer activo/a es un recurso fundamental para el bienestar. Vivir activamente es algo que se puede conseguir reemplazando actividades y roles que se abandonan, según se producen cambios vitales como la jubilación, por otros nuevos que tengan significados para las personas.

El envejecimiento activo es un recurso fundamental que ayuda a las personas y a las comunidades a realizar su potencial de calidad de vida y significación a lo largo de todo su ciclo vital y a participar en la sociedad de acuerdo con sus necesidades, deseos y capacidades, mientras que ésta les proporciona apoyos, protección, seguridad y cuidados adecuados.

Si se quiere hacer del envejecimiento una experiencia positiva, una vida más larga debe ir acompañada de oportunidades continuas de salud, participación y seguridad. La **Organización Mundial de la Salud** utiliza el término «envejecimiento activo» para expresar el proceso por el que se consigue este objetivo.

Es un referente clásico la definición de envejecimiento activo de la OMS: **El envejecimiento activo es el proceso de optimización de las oportunidades de salud, participación y seguridad con el fin de mejorar la calidad de vida a medida que las personas envejecen.**

El envejecimiento activo se aplica tanto a los individuos como a los grupos de población. Permite a las personas realizar su potencial de bienestar físico, social y mental a lo largo de todo su ciclo vital y participar en la sociedad de acuerdo con sus necesidades, deseos y capacidades, mientras que les proporciona protección, seguridad y cuidados adecuados cuando necesitan asistencia.

El término **«activo»** hace referencia a una participación continua en las cuestiones sociales, económicas, culturales, espirituales y cívicas, no sólo a la capacidad para estar físicamente activo o participar en la mano de obra. Las personas ancianas que se retiran del trabajo y las que están enfermas o viven en situación de discapacidad pueden seguir contribuyendo activamente con sus familias, semejantes, comunidades y naciones. El envejecimiento activo trata de ampliar la esperanza de vida saludable y la calidad de vida para todas las personas a medida que envejecen, incluyendo aquellas personas frágiles, discapacitadas o que necesitan asistencia.

El término **«Salud»** se refiere al bienestar físico, mental y social expresado por la OMS en su definición de salud. Por tanto, en un marco de envejecimiento activo, las políticas y los programas que promueven las relaciones entre la salud mental y social son tan importantes como los que mejoran las condiciones de salud física.

Mantener la autonomía y la independencia a medida que se envejece es un objetivo primordial tanto para los individuos como para los responsables políticos (véase el recuadro de definiciones). Además, el envejecimiento tiene lugar dentro del contexto de los demás: los amigos, los compañeros de trabajo, los vecinos y los miembros de la familia. Por ello, la interdependencia y la solidaridad intergeneracional (dar y recibir de manera recíproca entre individuos, así como entre generaciones de viejos y de jóvenes) son principios importantes del envejecimiento activo. El niño de ayer es el adulto de hoy y será la abuela o el abuelo de mañana. La calidad de vida que disfrutarán como abuelos dependerá de los riesgos y las oportunidades que experimenten a través de toda su vida, así como de la forma en que las generaciones sucesivas proporcionen ayuda y soporte mutuos cuando sean necesarios.

El término «envejecimiento activo» **fue adoptado por la Organización Mundial de la Salud a finales de los años 90** con la intención de transmitir un mensaje más completo que el de «envejecimiento saludable» y reconocer los factores que junto a la atención sanitaria afectan a la manera de envejecer de los individuos y las poblaciones (Kalache y Kickbusch, 1997).

El planteamiento del envejecimiento activo se basa en el reconocimiento de los derechos humanos de las personas mayores y en los Principios de las Naciones Unidas de independencia, participación, dignidad, asistencia y realización de los propios deseos. Sustituye la planificación estratégica desde un planteamiento «basado en las necesidades» (que contempla a las personas mayores como objetivos pasivos) a otro «basado en los derechos», que reconoce los derechos de las personas mayores a la igualdad de oportunidades y de trato en todos los aspectos de la vida a medida que envejecen. Y respalda su responsabilidad para ejercer su participación en el proceso político y en otros aspectos de la vida comunitaria.

5.2.- ELEMENTOS ESENCIALES: CALIDAD DE VIDA Y ENVEJECIMIENTO ACTIVO.

La complejidad de los procesos que propician que las personas vayan envejeciendo de forma activa, sin desvincularse de su entorno, hace que sea necesario trabajar desde un modelo que aúne dos elementos esenciales: el envejecimiento y la calidad de vida.

Los elementos que se incluyen en este modelo de envejecimiento activo se agrupan en torno a tres ejes:

La realidad multidimensional de la persona.

Múltiples dimensiones de la persona pueden verse mejoradas –con lo que aumentará la calidad de vida- si se adopta un estilo de envejecimiento activo. Estas dimensiones son las siguientes:

- El bienestar emocional: se produce cuando la persona experimenta sentimientos de felicidad y satisfacción, cuando se siente segura en los diferentes contextos y su autoconcepto le permite valorarse y aceptarse como es.
- El bienestar físico: es el que percibe la persona cuando se siente sana, asumiendo hábitos cotidianos correctos y se encuentra con un sistema adecuado de atención sanitaria.
- El bienestar material: está relacionado con el nivel socioeconómico de la persona.
- La inclusión social: es posible cuando la persona no ve dificultado su acceso a la comunidad y puede participar activamente en ella, pudiendo desarrollar roles socialmente aceptados.
- Las relaciones interpersonales: tienen que ver con la posibilidad de mantener interacciones significativas de amistad e intimidad con otros, con el sentimiento de pertenencia a un grupo y con disponer de una red de apoyo social.
- El desarrollo personal. Se refiere a la posibilidad de crecimiento personal, la mejora de las competencias personales o los niveles educativos a lo largo de la vida.
- La autodeterminación. Está relacionada con la posibilidad de elegir y tomar decisiones libremente y según las preferencias personales.
- Los derechos. Se refiere al derecho de las personas a la consideración de su dignidad individual, el derecho a dirigir su propia vida y hacerlo libremente, el derecho a la privacidad …

Los niveles de intervención de los agentes.

Se consideran tres niveles diferenciados sobre los que es necesario intervenir para promover procesos de envejecimiento activo:

- El **microsistema** de la persona: la persona y su entorno de relación inmediato –la familia, el grupo de iguales …-.
- El **mesosistema**: el vecindario, la comunidad, las agencias de servicios, las organizaciones públicas …
- El **macrosistema**: formado por los patrones culturales, las tendencias sociopolíticas, los sistemas económicos, los valores, las creencias …

Las fases de la implementación.

La promoción de procesos de envejecimiento activo requiere fundamentalmente cuatro estrategias, que son:

- La sensibilización.
- La formación.
- La experimentación o vivencia personal.
- El fortalecimiento o empoderamiento de personas y comunidades, a través de la participación y toma de conciencia, la autogestión e implicación de los ciudadanos, el fortalecimiento de la identidad personal y del sentido de la comunidad …

5.3.- CLAVES PARA EL ENVEJECIMIENTO ACTIVO.

Promover procesos de envejecimiento activo en los ciudadanos requiere:

- Modificar progresivamente los estereotipos negativos que pesan sobre la vejez y las personas mayores.
- Conseguir una comprensión amplia del envejecimiento activo por parte de personas mayores, políticos y sociedad en general.
- Modificar el actual modelo de trabajo de las instituciones más centrados en "hacer para" que en "hacer con", ya que ello facilitará una mayor implicación de los mayores en la construcción de su realidad.
- El envejecimiento debe ser un tema de compromiso de todas las áreas de las políticas públicas, no solo de los departamentos de servicios sociales y de sanidad.
- Hay que dejar de considerar a las personas mayores como un grupo homogéneo. La desconsideración de la diversidad inherente a cualquier ser humano empobrece a la colectividad y dificulta un diseño diversificado y adaptado de políticas, planes de acción, estrategias y recursos.
- Favorecer la participación de las personas mayores en foros abiertos a los ciudadanos en general –no solo en foros de mayores-. Esta participación debe ser reforzada por las instituciones a través de una perspectiva intergeneracional. La participación normalizada de los mayores sólo será posible con la eliminación total de barreras físicas y arquitectónicas del diseño urbanístico, del mobiliario urbano, de los transportes y de las infraestructuras comunitarias en general.
- Promover el asociacionismo de los mayores como recurso social para la participación social y la actividad significativa.
- Garantizar la igualdad de oportunidades para envejecer activamente de las personas mayores con algún grado de dependencia. Los centros de mayores –tanto no residenciales como residenciales- deben ser entornos estimulantes en los que se cree una cultura de la participación y se promueva el envejecimiento activo entre los residentes.
- Garantizar la igualdad para envejecer activamente de las mujeres mayores. Es necesaria una acción positiva que garantice a la mujer un tiempo para sí misma, dándola la posibilidad de tomar las riendas de su vida. Pueden ser necesarios recursos que proporcionen respiros, medidas de conciliación de la vida laboral y familiar, de formación específica …
- Ayudar a las personas a consolidar hábitos de ocio activos y saludables que sean fuente de estimulación física, cognitiva y social, y que proporcionen satisfacción y objetivos vitales. Son necesarias acciones específicas de animación lectora, turística, museística, educación para la salud, educación medioambiental …

5.4.- LA PERSPECTIVA DEL BUEN TRATO EN EL ENVEJECIMIENTO.

Los mayores, al igual que el resto de los ciudadanos, tienen derecho a vivir en entornos donde sean tratados con respeto. Como sujetos de pleno derecho el trato inadecuado es una incuestionable violación a tales derechos. El buen trato implica un reconocimiento de las posibilidades físicas y emocionales de los demás, empatía que permita ponernos en el lugar del otro, posibilidad de interaccionar positivamente …

La sociedad debe considerar a las personas mayores participantes y contribuyentes activos, y a la vez, beneficiarios de su desarrollo. Estos, como hemos visto, son principios importantes del envejecimiento activo. Otro aspecto a tener en cuenta es la **solidaridad intergeneracional**, dar y recibir de manera recíproca entre individuos y generaciones de mayores y jóvenes.

Es importante que existan políticas sociales que favorezcan la educación y el aprendizaje continuo, que protejan frente a la violencia y el abuso, que fomenten la participación activa de los mayores en la sociedad, que propicien redes sociales que ayuden al mayor a través del apoyo vecinal, atención a los familiares cuidadores, voluntariado, programas intergeneracionales y garanticen prestaciones sociales.

La línea divisoria entre el trato adecuado y el inadecuado es a veces muy frágil y sutil. Los mayores en ocasiones no son tratados como se debe por la sociedad, por las instituciones, por las propias familias … A nivel social con demasiada frecuencia se dan situaciones donde al mayor se le trata de forma denigrante, se le margina …

Las situaciones de abuso son frecuentes, sin reparar en el daño que se les hace al no tener en cuenta su rol en la familia, su autoridad, sus propuestas … (negarles el control de la cartilla, utilizar su dinero sin consultar con ellos, tomar decisiones por ellos, hacerles asumir tareas no elegidas, no permitirles intervenir en conversaciones …).

En otras ocasiones lo que sucede es un trato negligente en el cuidado: falta de adecuada higiene, no se cubren sus necesidades básicas (alimentos, vestido, medicamentos), no se tiene en cuenta la necesidad que tienen de refuerzos positivos …

Existen situaciones, menos frecuentes, de maltrato físico: zarandeos, golpes … El problema de los malos tratos en los mayores es complejo, es un fenómeno oculto difícil de detectar.

5.5.- EL ÍNDICE DE ENVEJECIMIENTO ACTIVO DE LA CIUDAD DE MADRID.

El Ayuntamiento de Madrid, miembro de la **Red Mundial de Ciudades Amigables con las Personas Mayores,** ha incluido el **Índice de Envejecimiento Activo** (IEA) en la evaluación de su Plan de Acción 2017-2019, con el fin de disponer de un elemento común al resto de la Unión Europea. Se ha considerado, a priori, como una herramienta idónea tanto para la comparación con otras áreas o ciudades como por su valor en el seguimiento longitudinal a largo plazo.

Madrid es la ciudad más grande del estado español en términos de población y su esperanza de vida la más elevada. La población mayor de 55 años es de 1.030.955, suponiendo el 32% de la ciudadanía, cifra muy superior a la del resto de los municipios de nuestra comunidad autónoma (25,8%) y cabe suponer que su peso en los cálculos realizados en nuestro país, y en especial en nuestra comunidad autónoma, sea alto. Madrid es la primera ciudad que, en el seno de la Unión Europea, ha realizado este cálculo.

La definición de envejecimiento activo que se recoge es "**la situación en la que las personas siguen participando en el mercado laboral, así como en otras actividades productivas no remuneradas (como la prestación de atención a familiares y voluntariado) y viven vidas saludables, independientes y seguras a medida que envejecen**". Esta definición adquiere un valor económico / productivo superior al manejado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) a raíz de la II Asamblea Mundial de las Naciones Unidas sobre el Envejecimiento, celebrada en 2002 en Madrid, en la que el "Envejecimiento Activo" fue definido como "**el proceso de optimización de las oportunidades de salud, participación y seguridad con el fin de mejorar la calidad de vida a medida que las personas envejecen**" (OMS, 2002).

En cierto modo, al beneficio individual de envejecer activamente, se añade el **beneficio social.** Al ser más saludables como grupo, las personas mayores tienen el potencial de contribuir no solo a su propio bienestar sino también a sostener una creciente prosperidad económica y social para nuestras naciones. Estos nuevos paradigmas de envejecimiento activo y saludable motivan el trabajo de creación del índice. Para su construcción se utilizan una serie de indicadores que se agrupan en cuatro dimensiones: **empleo, participación social, vida independiente y segura, y capacidad para un envejecimiento saludable.** Es una herramienta de medición comparada entre países acerca del potencial de las personas mayores para tener un envejecimiento activo y saludable.

6.- POLÍTICAS DE PREVENCIÓN DE LA SOLEDAD NO DESEADA.

6.1.- LA SOLEDAD NO DESEADA.

En los últimos tiempos la soledad no deseada está siendo significada como una cuestión de salud pública a nivel global. Tanto es así que algunos gobiernos como el del Reino Unido en 2018 o el de Japón en 2021 han creado órganos ministeriales para afrontar el problema como una cuestión de Estado. En el caso de Reino Unido, tras una comisión que concluía que la soledad afectaba a nueve millones de personas en el país. En el de Japón, con el propósito de dar seguimiento y revertir el incesante aumento de la tasa de suicidios.

Esta problemática se ha visto agravada y visibilizada a raíz de la pandemia por Covid-19, evidenciándose así sobremanera la fragmentación de las relaciones sociales, los sentimientos de soledad y la escasa atención proporcionada a la salud mental como problemas sociales que ya existían previamente y que impactaban, y han impactado, en mayor medida sobre las personas en situación de vulnerabilidad.

Una de las definiciones más aceptadas del **concepto de soledad no deseada**, desde un análisis cognitivo, la describe como una discrepancia entre las relaciones sociales que una persona desearía tener y las que realmente tiene. De esta forma, la red de relaciones sociales sería menor o menos satisfactoria de la deseada desde una percepción subjetiva. Esta definición diferencia el sentimiento de soledad no deseada de la situación de aislamiento social, ya que esta última cuestión se da a través de una circunstancia objetiva y continuada de carencia de contactos sociales. Alineada con esta concepción, se puede decir que esta discrepancia podría dar lugar a una experiencia negativa de la soledad y/o a un sufrimiento, angustia o aflicción por sentimientos de aislamiento social, aun cuando la persona pueda encontrarse rodeada de familiares o amistades.

Los sentimientos de soledad no deseada podrían deberse a eventos o cambios en la vida de las personas, estando sujetas a la experiencia vital, es decir, a lo individual; pero también suponen una propiedad grupal, ya que se conoce que existe un efecto contagio, principalmente entre amistades cercanas geográficamente y que mantienen contactos físicos, existiendo así un patrón de red social en la soledad no deseada, un carácter social de la soledad no deseada.

Integrando las aportaciones de diferentes autores, existen tres dimensiones de la soledad no deseada: **la dimensión íntima, la dimensión relacional y la dimensión colectiva**. Estas tres dimensiones en combinación plasman toda la diversidad de contactos sociales que las personas necesitan para sentirse bien. La escasez o debilidad percibida de contactos en cualquiera de las tres dimensiones podría generar sentimientos de soledad. Resulta relevante aquí señalar también la diferenciación que propone Young (1982) entre distintos tipos de soledad no deseada en función de su duración en el tiempo, siendo diferentes según su carácter crónico, situacional o temporal.

Los datos sobre la percepción de la soledad no deseada del **Observatorio Estatal de la Soledad No Deseada (2022) de la Fundación ONCE** determinan que, en 2022, más de un 10% de las personas consultadas se han sentido solas de manera frecuente en el último año y que un 25,1% se han sentido solas ocasionalmente. Que existe un mayor porcentaje entre mujeres (12,9%) que entre hombres (9%) en el rango definido como de más frecuencia. También que las personas de entre 16 y 39 años son las que con más porcentaje se han sentido solas en el último año (16%) frente a las de entre 40 y 54 años (9,5%) y las de entre 55 y 74 años (5,6%). Y que más de un 9% de las personas consultadas no tiene a nadie que le pueda ayudar cuando tiene problemas. El Observatorio también concluye que un 92,9% de las personas consultadas piensan que la soledad no deseada es un problema de primer orden, y que una de cada cuatro piensa que es uno de los dos principales problemas sociales del país.

Podemos conocer también el impacto de la soledad no deseada en la escala urbana a través de **un estudio (Rodríguez Pérez, Díaz-Olalla, Pedrero Pérez, y Sanz Cuesta, 2020) sobre esta realidad en la ciudad de Madrid**. En él se ha reflejado, en cuanto a la soledad percibida, indicador relacionado con la soledad no deseada, que un 10 por ciento de las personas encuestadas en el estudio refiere sentirse sola bastantes veces, siempre o casi siempre, siendo mayores los datos entre mujeres (12,5%) que entre hombres (7,6%). Este sentimiento de soledad, sin importar la situación de vivir en soledad o acompañado, es más frecuente entre quienes dicen tener dificultades económicas y se encuentran en una clase social más desfavorecida, reduciéndose significativamente en otras categorías más favorecidas. También es más prevalente entre quienes tienen estudios primarios, siendo esta tendencia más acusada también nos obliga a centrar la mirada sobre las situaciones de vulnerabilidad y la cuestión de género.

Se puede concluir así que la etiología y las consecuencias de la soledad no deseada son complejas, que es una condición que puede convertirse en una aflicción para cualquier tipo de persona, que es un problema que genera amplios riesgos para la salud pero que recibe aún poca atención desde el ámbito sanitario y que en un futuro se prevé que se puedan combinar intervenciones cognitivo-conductuales con tratamientos farmacológicos para reducir su prevalencia y sus consecuencias.

6.2.- ESTRATEGIA MUNICIPAL CONTRA LA SOLEDAD EMOCIONAL O RELACIONAL EN LAS PERSONAS MAYORES.

El Ayuntamiento de Madrid aprobó la **Estrategia Municipal contra la soledad emocional o relacional en las personas mayores**, dentro de los acuerdos planteados en los llamados **Pactos de la Villa** (acuerdos que se toman por unanimidad de todos los grupos políticos en julio de 2.020 en el contexto posterior a la pandemia del Covid).

Como **objetivo general**, se busca **contribuir a disminuir el sentimiento de soledad de las personas mayores a través del fortalecimiento de la amigabilidad de la ciudad de Madrid, la sensibilización a la ciudadanía, la detección de riesgos y la intervención sobre la soledad y sus consecuencias**, todo con el deseo de mejorar la realidad en la que vivimos, en especial para los mayores que se sienten solos y aislados.

Esta estrategia se basa en cuatro pilares:

1. 'MADRID, MÁS CERCA DE TI'
Se encarga de dar uniformidad a las actuaciones, detectando problemas que aún no han emergido, anticipándose a la necesidad y dotando de homogeneidad a los registros, de modo que la evaluación sea más sencilla y eficaz**.**
2. 'MADRID TE ACOMPAÑA'
En el campo del acompañamiento se ha puesto en marcha una aplicación denominada *Madrid te acompaña*,que consiste en un sistema soportado por una *app* que pone a disposición de las personas mayores un voluntario para gestiones y acompañamiento puntuales diversos, contando a su favor con la cercanía del voluntario a la persona mayor que lo necesita. Una innovación en el campo del acompañamiento llevado a cabo por Voluntarios por Madrid. Se trata no solo de acompañar sino de crear vínculos y proporcionar ayuda, convirtiéndose, además, en "antenas" para la detección de situaciones de soledad no deseada u otros riesgos, favoreciendo la atención por la red con la que la estrategia cuenta.

3. 'MADRID EN RED'

Madrid en red o *Madrid vecina*, es una forma innovadora de tejer redes sociales y de posicionar a las personas mayores en el corazón del barrio. Se centra en el trabajo comunitario, la potenciación de las redes sociales y el acompañamiento afectivo.

Se ha denominado Madrid en red o Madrid vecina y pivota especialmente en el trabajo comunitario y cuenta con la inestimable colaboración de la Fundación Grandes Amigos. A su proyecto de larga trayectoria de Grandes Vecinos, que ya viene actuando en el municipio desde hace unos años, se incorporan nuevas líneas de detección y coordinación, sin dejar a un lado el acompañamiento emocional.

El programa Grandes Vecinos, desarrollado por Grandes Amigos en colaboración con el Ayuntamiento de Madrid a lo largo de los últimos años, es una iniciativa puesta en marcha con el fin de recrear la solidaridad vecinal y poner en contacto a personas mayores con sus vecinos/as en un espíritu de respeto y libertad mutua. Este programa, es una forma innovadora de tejer redes sociales y de posicionar a las personas mayores en el corazón de barrio. De manera muy sencilla, permite poner en relación a personas que viven cerca y que, con acciones muy simples, pueden ayudar a paliar la soledad de las personas mayores del barrio y mejorar su calidad de vida.

Tras el éxito de esta iniciativa y la detección de las necesidades existentes en el entorno con la experiencia de su implantación, se planteó la ampliación de este programa, considerando un abordaje integral de la soledad desde el ámbito de la detección, la coordinación, la intervención y la prevención de la misma, implicando a la sociedad en esta misión con el foco en tres cuestiones: el trabajo comunitario, la potenciación de las redes sociales (a través de Grandes Vecinos) y el acompañamiento afectivo. Tres ejes que se apoyan y se enriquecen entre sí y que facilitan conjugar el voluntariado y la acción vecinal como vehículos para la inclusión, la transformación social, el desarrollo humano, la prevención de la soledad en sus diferentes dimensiones y mejorar la calidad de vida de las personas mayores y las personas y agentes involucrados.

La página web de "Madrid Vecina" recoge la visión más global del proyecto, la de mayor calado comunitario, definiéndola como una red de apoyo vecinal que busca detectar y prevenir situaciones de soledad en las personas mayores. "Conectamos a vecinas/os, comercios, agentes sociales de las administraciones públicas, asociaciones vecinales… Entre todas formamos una red para estar pendiente de las personas mayores de nuestro entorno, saber si están o se sienten solas, echarles una mano en lo que necesiten y facilitar su socialización y participación en la vida del barrio".

Actúan como "antenas" y se integran en la estrategia global tanto en la detección como en la intervención.

4. 'MADRID CONTIGO'

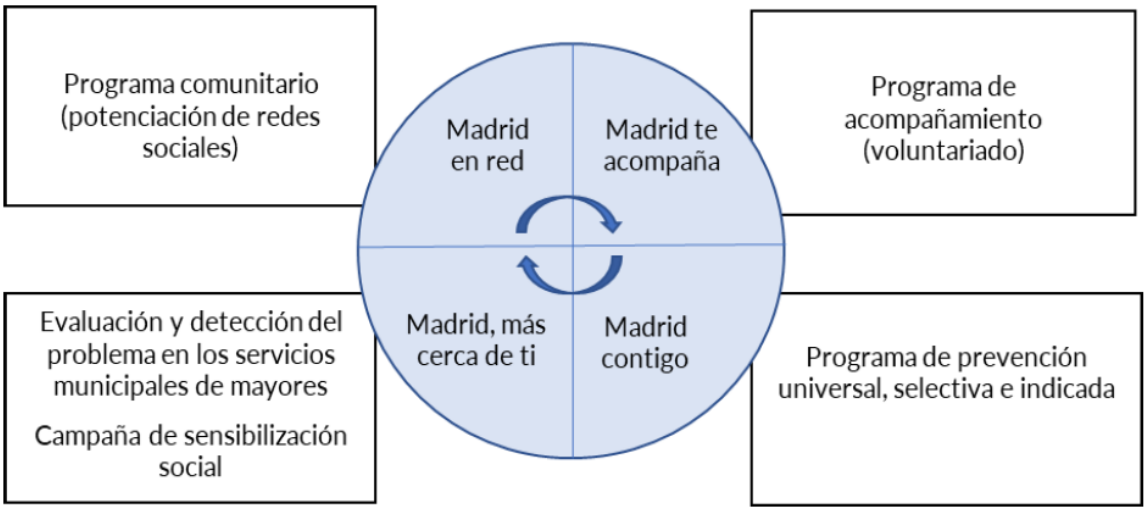
Se basa en la potenciación de las actividades encaminadas a paliar la soledad en todos y cada uno de los programas y servicios existentes (Centros de Día, Teleasistencia, Servicios Domiciliarios de Atención Directa, etc.) además de la puesta en marcha de nuevos recursos: actividades grupales, visitas a domicilio, equipos distritales, etc., poniendo el énfasis en la prevención primaria, secundaria y terciaria de la soledad no deseada, para la cual, no podemos dejar a un lado la detección que nos permitirá actuar en cada grupo de personas de una manera específica.

El uso de instrumentos comunes es de gran ayuda, sea cual sea la población sobre la que se desee actuar y la estrategia precisa para ella.

Se hace referencia a la prevención universal, primaria en el argot sanitario, siendo un ejemplo los talleres formativos de envejecimiento activo en centros municipales. Este tipo de prevención no requiere de selección alguna, se dirige a la población general, sin riesgo conocido, al igual que las acciones de sensibilización.

En la prevención selectiva, secundaria, los factores de riesgo están presentes y se hace necesaria la identificación de los mismos. También sirven como ejemplo las actividades grupales.

Al referirnos a la prevención indicada, terciaria, en la estrategia se contempla tanto la intervención individual o grupal.



En el desarrollo de esta Estrategia se han implicado los servicios y programas que ya trabajaban en el ayuntamiento con las personas mayores:

Centros municipales de mayores.

Son un auténtico recurso de socialización. Sus actividades grupales, educativas o de ocio ya cumplen una función clara frente a la soledad. El fomento del voluntariado, los grupos de acogida y las actividades grupales descritas anteriormente reforzaran su papel. Además, existe un compromiso de mejora en su carta de servicio. Actúan en todos los niveles de prevención y hay que señalar que alrededor de la mitad de la población mayor de 65 años de Madrid es socia de los centros, de ahí su gran potencial.

Centros de día.

Dada su forma de trabajo, basado en el modelo de atención centrada en la persona, el abordaje de los sentimientos de soledad no es ajeno a su labor cotidiana.

Residencias municipales.

Con un impacto poblacional menor dado su escaso número, no hemos de olvidar que la soledad en las residencias de personas mayores es de una frecuencia inusual. También aquí se trabaja con el modelo de atención centrado en la persona y se hace una intervención integral.

Apartamentos para mayores.

También escasos numéricamente, se incluyen en la detección de soledad e impulso al uso de servicios comunitarios, especialmente los centros de mayores y sus actividades de socialización.

Teleasistencia.

Es un recurso contra la soledad en sí mismo ya que no solo ofrece seguridad sino también compañía. Es enorme su potencial de detección e intervención, así como sus grandes beneficios. Por esa misma razón, la carta de servicios ha incluido la mejora del trabajo en soledad no deseada. Simplemente, la valoración de los nuevos usuarios puede detectar e intervenir en gran cantidad de casos. Tras un cribado inicial, la cercanía de los teleoperadores puede detectar casos de soledad no deseada que además puede abordarse por el equipo de psicólogos. Es de destacar la firma de un convenio entre las entidades prestadoras del servicio y las tres ONG con las que mantenemos convenios para la realización de un pilotaje de detección y derivación, que ya se ha puesto en marcha.

Servicios domiciliarios de atención directa.

El mayor potencial se encuentra en el servicio de ayuda a domicilio, por el gran número de usuarios. El uso de herramientas de cribado al alta y de información de recursos existentes dentro del propio servicio, específicas para el tema, o las mencionadas a lo largo de este documento pueden ser suficiente en algunos casos. Para los más complejos puede ser útil el equipo de intervención en domicilio de nueva creación. También aquí se ha incluido como mejora en la carta de servicio el incremento en el trabajo en soledad no deseada.

En el caso de las comidas a domicilio, la situación es semejante en cuanto a la detección y también hay actividades de socialización. El equipo de intervención en domicilio puede ser de utilidad aquí, al igual que en otros servicios domiciliarios que también pueden ser detectores.

Otros servicios.

Tanto los de carácter más activo (como el ejercicio al aire libre) como los de carácter más asistencial (los destinados a cuidadores) son potenciales detectores y socializadores en sí mismos. En el caso de "Cuidar a quienes cuidan", ya se trabaja la soledad no deseada de manera específica y se valora en los seguimientos anuales. No obstante, se ha intensificado la actividad en el nuevo contrato, de manera que, a las sesiones habituales, terapéuticas, educativas o de autoayuda, se han unido sesiones especificas socializadoras.

Como refuerzo de todo lo anterior se cuenta con un nuevo servicio de visitas domiciliarias, nuevas actividades grupales y equipos de atención a las personas mayores vulnerables en los distritos.

Equipo de visitas domiciliarias.

Para la valoración de la soledad emocional o relacional, cuya finalidad es el contacto y enganche que permita establecer una relación de confianza y realizar una valoración del caso y ayudar a la persona mayor a establecer sus objetivos, contado con técnicos en integración social. Tras la valoración de las características individuales y sus circunstancias, se hace una aproximación a la posible soledad emocional o relacional, y se informa de las distintas posibilidades o recursos más adecuados a su situación, tanto fuera como dentro del hogar.

Actividades grupales preventivas para desarrollar en centros municipales.

Destinadas a hacer prevención universal, con contenidos sobre generatividad, participación, productividad y derechos, discriminación por edad, o el estigma de la soledad en las personas mayores. Se trata de aprender a gestionar el proceso de envejecer y siempre con perspectiva de género. Otras destinadas a la prevención selectiva, en la que los factores de riesgo están presentes y se hace necesaria la identificación de los mismos. Dos tipos de intervenciones básicas, las que pretenden mejorar las habilidades sociales y las que tienen como finalidad fortalecer el apoyo social. Las de prevención indicada requieren un programa completo, psicoterapéutico, destinado a quienes presenten sentimientos de soledad no deseada, detectados y medidos con herramientas validadas. Están conducidos por personal de la rama de la psicología o la educación social.

Equipos de detección de vulnerabilidad de personas mayores.

Se trata de equipos técnicos para el abordaje de casos complejos de intervención con personas mayores, relacionados con el maltrato, la vulnerabilidad, la soledad, con un enfoque de detección precoz y prevención de situaciones no deseables. Aunque no son específicos para soledad no deseada, sin duda resultarán de gran ayuda para la acción coordinada en el territorio, especialmente en los casos de soledad asociada a necesidad social o sociosanitaria. Actualmente en fase de pilotaje.

Bibliografía

. Madrid, Ciudad Amigable con las personas mayores. Plan de Acción, 2.019-2.023.
https://www.madrid.es/UnidadesDescentralizadas/Mayores/Especial%20informativo/Madrid,%20ciudad%20amigable/Plan%20de%20Acción%20Madrid,%20ciudad%20amigable%20con%20las%20personas%20mayores%202021-23.pdf

. Fomento de la imagen adecuada del envejecimiento.
https://www.madrid.es/UnidadesDescentralizadas/Mayores/Especial%20informativo/Madrid,%20ciudad%20amigable/Fomento%20de%20la%20imagen%20adecuada%20del%20envejecimiento.pdf

. Mapa Estratégico y Plan Operativo de Gobierno, 2.019-2.023.
https://www.madrid.es/UnidadesDescentralizadas/Calidad/Observatorio_Ciudad/02_SG_Estrategica/Ficheros/Mapa%20y%20POG%202019-2023_marzo_1786.pdf

. Índice de envejecimiento activo de la Ciudad de Madrid.
https://www.madrid.es/UnidadesDescentralizadas/Mayores/Especial%20informativo/Madrid,%20ciudad%20amigable/%C3%8Dndice%20de%20envejecimiento%20activo%20en%20la%20ciudad%20de%20Madrid2.pdf

. Estrategia municipal contra la soledad emocional o relacional en las personas mayores.
https://www.madrid.es/UnidadesDescentralizadas/Mayores/Especial%20informativo/Soledad/Estrategia%20municipal%20contra%20la%20soledad%20emocional%20o%20relaconal%20en%20las%20personas%20mayores.pdf